

המועצה המדעית ועדת הבחינות

בחינות שלב א' 2022
רפואת המשפחה

מס' השאלות בחלק זה: 150

1. באיזו אינדיקציה ניתן לטפל ב-Direct oral anticoagulant (DOAC) כתחליף לטיפול ב-Warfarin)? Coumadin?

- א. מטופלת עם אירוע של DVT לראשונה בחייה על רקע APLA.
- ב. מניעת אירועים אמבולים במטופל עם MITRAL STENOSIS בדרגה בינונית.
- ג. מניעת אירועים אמבולים במטופל עם מסתם מלאכותי מכני.
- ד. מניעת VTE ראשונית לאחר ניתוח החלפת ירך.

2. בן 26, אסטמה מילדות, מטופל ב-160/4.5 Symbicort (Budesonide + Formoterol) מק"ג/מנה פעם בבוקר. מלין על שיעול וקוצר נשימה מעיר משינה, נזקק למשאף Ventolin (Salbutamol) להקלה רוב ימי השבוע. בתפקודי ריאות התמונה הבאה:

FEV1	2.7L	56% predicted
FEV1/FVC	54%	

על פי הנחיות GINA מה הטיפול המומלץ עבורו?

- א. Singular (Montelukast).
- ב. 160/4.5 Symbicort מק"ג/מנה פעמיים ביום.
- ג. 320/4.5 Symbicort מק"ג/מנה פעמיים ביום.
- ד. הוספת טיפול ב-Spiriva (Tiotropium).

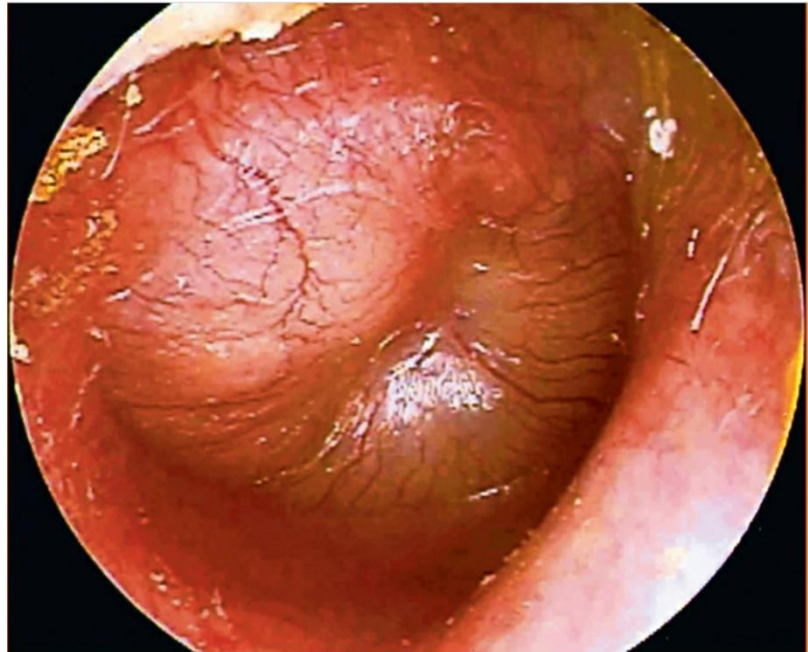
3. בת 72 מלינה שלא ישנה טוב בשנה האחרונה ומבקשת כדור שינה כי מרגישה עייפה במהלך היום ומתעצבנת בקלות. ללא עדות למחלה גופנית או סימנים בולטים של הפרעה נפשית. מהי ההמלצה המתאימה ביותר לגבי הטיפול בתלונתה?

- א. במצבה אין מדובר בהפרעת שינה כי לא נעשתה עדיין בדיקת פוליסומנוגרפיה.
- ב. מומלץ להתחיל טיפול בתכשירים לא ממכרים כתמצית פסיפלורה.
- ג. בגילה טיפול מועדף הוא ב-Mirtazapine (Miro).
- ד. במצבה מומלץ גם טיפול תרופתי וגם טיפול התנהגותי.

4. בת 27, בריאה בד"כ, הריון ראשון. בשבוע 5 (+3) נצפה שק הריון תוך רחמי ללא דופק. מגיעה למרפאה בשבוע 8 עקב דמם וגינלי קל, ללא כאבי בטן. בבדיקתה סימנים חיוניים תקינים, בטן רכה. מהי ההמלצה המתאימה ביותר למטופלת?

- א. מאחר ולא היה דופק בשבוע 5 (+3), כנראה מדובר בהריון שלא התפתח ומדובר בהפלה.
- ב. מומלצת מנוחה במיטה כדי להפחית את הסיכוי לאובדן ההריון.
- ג. דמם בטרימסטר ראשון הוא תופעה לא שכיחה ולכן מחייב בירור הפרעת קרישיות.
- ד. עליה לבצע בדיקת אולטרסאונד ורמת β -hCG בדם.

5. בן שנה, בריא ומחוסן לפי גילו. מזה 3 ימים ירידה בתיאבון ואי שקט, חום 39.4 מ.צ. בדיקתו הגופנית תקינה למעט ממצא באוזן ימין שבתמונה:



מהו הטיפול המומלץ כעת?

- א. שיכוך כאב מקומי ומעקב חוזר במרפאה עוד 48 שעות.
- ב. Amoxicillin (Moxypen) פומי במינון 90 מ"ג/ק"ג/יום ומתן טיפול אנלגטי לפי הצורך.
- ג. טיפול אנלגטי פומי במינון תואם למשקל התינוק ומעקב חוזר במרפאה עוד 48 שעות.
- ד. Ciprofloxacin (Ciloxan) טופיקלית וטיפול לשיכוך כאב לפי הצורך.

6. לכל המטופלות הבאות יש בבדיקות המעבדה ערכים המתאימים לתת תרסיות תת קלינית (Subclinical hypothyroidism).

באיזו מהמטופלות יש התוויה חד משמעית להתחיל טיפול ב-Levothyroxine?

א. בת 40, שבחודשיים האחרונים עלתה 5 ק"ג במשקל.

ב. בת 50, רמת LDL-C 160.

ג. בת 30, עם סיפור משפחתי של תת תרסיות אצל האם בגיל צעיר.

ד. בת 25 שמתכננת להיכנס להריון.

7. באילו מהמקרים הבאים מומלץ לתת טיפול אנטיביוטי לזיהום ב-Salmonella?

א. בן 75, ללא מחלות כרוניות ברקע.

ב. בת 20, בריאה בדרך כלל, חזרה מטיוול בהודו.

ג. בן 8 שנים עם Thalassaemia Minor.

ד. בת 45 עם סוכרת מאוזנת.

8. מהן דרכי המניעה הראשונית להתפתחות Age Related Macular Degeneration (AMD)?

א. תוספי חומצה פולית, וויטמין B12.

ב. הפסקת עישון.

ג. איזון ערכי סוכר.

ד. מתן חומצות שומן Omega-3.

9. במקרה של חוסר התאמה בין ערכי סוכר בצום לערכי Hemoglobin A1C, מהי הבדיקה הרגישה ביותר לאבחון סוכרת?

- א. Hemoglobin A1C.
- ב. ערכי סוכר שעתיים לאחר העמסה של 75 גרם גלוקוז.
- ג. ערכי סוכר בצום.
- ד. בדיקת Fructosamine.

10. בת 28, בהריון ראשון, לקראת לידה. איזה מצב מחייב דיווח למשרד הבריאות בהודעה אינדיבידואלית?

- א. Cytomegalovirus (CMV).
- ב. הרפס גניטלי.
- ג. כלמידיה טרכומטיס בדרכי המין.
- ד. Pneumococcal Pneumonia.

11. בן 73, ברקע - לחץ דם, סוכרת ועודף שומנים בדם. סובל מזה 6 חודשים מקשיי נשימה וכאבים בחזה במאמץ ו-paroxysmal nocturnal dyspnea. לחץ דם 135/85 מ"מ"כ. הטיפול התרופתי הנוכחי:

Bisoprolol 1.25mg*1/d, Glucomin 850mg*1/d, Lercanidipine 10 mg*1/d
 .Ramipril 5mg*1/d, Atorvastatin 10mg*1/d

מה יהיה הטיפול היעיל ביותר למצבו הנוכחי של המטופל?

- א. החלפת Bisoprolol ב-Normalol.
- ב. הפסקת Lercanidipine.
- ג. העלאת מינון Atorvastatin.
- ד. תוספת 100 Aspirin מ"ג.

12. בן 74, פנה למרפאה לחידוש מרשמים קבועים.
מהי ההמלצה לביצוע בדיקת סקר לאיתור ירידה בשמיעה במטופל זה?

- א. מומלץ לבצע לשימור תפקוד קוגניטיבי.
- ב. אין המלצה לבצע אם אין תלונות על ירידה בשמיעה.
- ג. מומלץ לבצע מעל גיל 50.
- ד. יש לבצע מבחן "דיבור בלחש" רק במקרים של נפילות חוזרות.

13. מהי ההטיה השכיחה ביותר למחקרי Case Control?

- א. Selection Bias
- ב. Referral Bias
- ג. Verification Bias
- ד. Recall Bias

14. בן 7, בריא בד"כ, מזה תקופה יש אזור בקרקפת ללא שיער ולאחרונה החל לכאוב. בהסתכלות:



בהתחשב באבחנה הסבירה ביותר מהו הטיפול המתאים במידה ואין אפשרות לקחת משטח?

- א. Tab.Lamisil (Terbanifine)
- ב. Tab.Grifulin (Griseofulvin)
- ג. Shamp.Nizoral (Ketoconazole)
- ד. Cream Agispor (Bifonazole)

15. בת 35, סובלת מהתקפי מיגרנה בתדירות 1-2 לשבוע, המפריעים לעבודתה. מטופלת בתכשיר משולב, המכיל אספירין, פראצטאמול וקפאין, לפי הצורך. ברקע - אסטמה, השמנה ונטייה לעצירות. מהו הטיפול המונע המתאים ביותר אצל מטופלת זו?

א. Topiramate

ב. Sumatriptan

ג. Atenolol

ד. Amitriptyline

16. בת שנתיים הובאה למרפאה בשל תלונות על גרד מפושט המחמיר בשעות הלילה. בבדיקתה – נגעים עוריים (ראה תמונה מצורפת):



מהו ההסבר לאם לגבי הטיפול המומלץ?

א. יש למרוח את המשחה על כל הגוף מהצוואר ומטה. להשאיר את המשחה למשך 14 שעות. יש למרוח בשנית כעבור שבוע.

ב. הטיפול הטופיקלי לא מתאים לפעוטה לאור גילה, על כך יש לרשום טיפול פומי ב-Ivermectin.

ג. יש להחליף את הטיפול אם כעבור שבועיים הגרד לא חלף.

ד. אין צורך לכבס בגדים או מצעים מאחר והמחולל לא שורד על מצע החיצוני לעור.

17. מטופל שסובל מצרבות ממושכות ביצע גסטרוסקופיה. נמצא Barrett's Esophagus with low grade dysplasia.
מהו המעקב המומלץ עבורו?

- א. גסטרוסקופיה חוזרת עוד 3 שנים וטיפול קבוע ב-PPI'S
- ב. גסטרוסקופיה חוזרת עוד 3 חודשים וארדיקציה ל-H.Pylori
- ג. גסטרוסקופיה חוזרת עוד שנה וטיפול קבוע ב-PPI'S
- ד. גסטרוסקופיה חוזרת עוד 5 שנים ו-ANTACIDS בשתייה

18. למי מבין המטופלים הבאים יכול הפסיכיאטר המחוזי להוציא הוראת בדיקה כפויה לא דחופה?

- א. חולה בסכיזופרניה, מזה שבועיים מסרב לקחת את התרופות שלו ולדברי אביו הוא שוב מדבר על קולות שאומרים לו מה לעשות.
- ב. חולה במחלה דו קוטבית, הפסיקה טיפול ומסרבת להיבדק. הוריה דיווחו שהיא לקחה מהם כספים רבים וגורמת לנזק כלכלי.
- ג. חולת OCD, עקב שטיפת ידיים מתמשכת פיתחה פצעים מוגלתיים אך מסרבת לקבל אנטיביוטיקה.
- ד. מטופל לוקה בדיכאון, מטופל תרופתית ובמעקב רפואי. אשתו התקשרה להגיד שהוא מאיים להתאבד ולא מוכן להגיע לבדיקת רופא.

19. מה השיקול העיקרי להחלטה על טיפול ניתוחי בקטרקט?

- א. קיימת הפרעה בראיה לרחוק.
- ב. העדשה הופכת לעכורה.
- ג. במטופל/ת מעל גיל 70.
- ד. המטופל מדווח על פגיעה באורח החיים היומיומי.

20. מטופל מעוניין להפסיק לעשן.

מהם ההסברים בהתייחס לתופעות הלוואי של תהליך הגמילה מעישון?

- א. העלייה במשקל הצפויה מהפסקת העישון פוגעת בתועלת שבהפסקת העישון.
- ב. החמרת השיעול והליחה בעקבות הפסקת העישון שכיחה וזמנית, ואינה מבטאת החמרת COPD.
- ג. השימוש בסיגריה אלקטרונית לצרכי גמילה יעיל ומאושר על ידי ה-FDA.
- ד. הטיפול בתחליפי ניקוטין גורם לעליית ל"ד ודופק וקשור בסיכון לתופעות טרומבוגניות.

21. לפניך 4 מטופלים שונים אשר סובלים מפלפיטציות.

איזה מטופל מהבאים יכול לעבור את הבירור באופן אמבולטורי?

- א. בן 40, ברקע HOCM (Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy), הסובל מדיספניאה מזה 3 ימים.
- ב. בן 50, ברקע צנתור עם התקנת תומכן DES לפני כשנתיים. בהולטר הודגם non-sustained VT של 5 פעימות.
- ג. בת 30, כעת במרפאה בשל דפיקות לב. באק"ג SVT, מתלוננת על קשיי נשימה.
- ד. בן 50, בריא בדרכ"כ. מבצע כעת מבחן מאמץ בו נמדד QTc=480 msec.

22. בת 78, מתלוננת על קשיי הירדמות ויקיצות מרובות מזה כשנה. היא לוקחת מדי פעם Vaben

(Oxazepam) שמאוד עוזר לה אבל חוששת מתופעות לוואי.

מהי ההמלצה היעילה ביותר עבורה?

- א. טיפול קוגניטיבי התנהגותי.
- ב. החלפת הטיפול ל-Bondormin (Brotizolam).
- ג. הדרכה להיגיינת שינה והפסקת הטיפול התרופתי.
- ד. טיפול באנטי-היסטמיניקה כמו Tonight (Doxylamin).

23. בת 82, מתלוננת על חוסר תאבון וירידה במשקל ללא תלונות נוספות. ירדה במשקל מ- 60 ק"ג ל- 55 ק"ג בתשעת החודשים האחרונים. בדיקה גופנית תקינה. מהי ההמלצה המתאימה לבירור תלונתה?

- א. אין מדובר בירידה משמעותית במשקל כי לא ירדה 10% ממשקל גופה.
- ב. בגילה יש אינדיקציה חד משמעית לבירור אנדוסקופי של מערכת העיכול.
- ג. בשל ריבוי גורמים אפשריים לירידת משקל מומלץ CT חזה ובטן.
- ד. יש לכלול תשאול אקטיבי של תסמיני דיכאון.

24. בן 7 שנים, בריא בדרך כלל, ללא מחלות במשפחה, התחיל להשתתף בחוג כדורסל השנה. במהלך שני האימונים בהם השתתף פיתח תפרחת מגרדת. בפעם האחרונה היה גם ריור יתר. הפריחה והריור חולפים כשעה לאחר סיום ההתעמלות. האם נזכרה באירוע דומה לאחר מקלחת חמה מידי בעבר. אימו צילמה את התפרחת באימון האחרון:



מהו הבירור המומלץ עבור הילד?

- א. ביופסיית העור.
- ב. Protoporphyrin בכדוריות הדם האדומות וצואה.
- ג. בדיקת דם ל- C4, C2, CH₅₀, C1-INH.
- ד. לא דרוש בירור.

25. בן 60, מעד ונחבל בראשו. עד שנכח באירוע מתאר איבוד הכרה לכמה דקות, ללא רעד/פרקוס או יציאת קצף מהפה. המטופל הגיע לבדיקה 3 שעות לאחר האירוע, מתלונן על כאב ראש. לא מטופל במדללי דם. בבדיקה - בהכרה מלאה, מתמצא ומשתף פעולה, ללא חשד לשבר בגולגולת/פגיעה בעמוד שדרה צווארי או סימנים נוירולוגים פוקליים. ללא סימני נשיכת לשון או איבוד שליטה על סוגרים. בזמן הבדיקה המטופל מרגיש בחילה ומקיא הקאה בודדת. מהי ההמלצה המתאימה ביותר?

- א. אין צורך בהדמיה מוחית כעת, יש להסביר באילו מקרים יש להיבדק בדחיפות.
- ב. נדרשת הדמיית מח עקב תסמינים לאחר 3 שעות מחבלת הראש והקאה.
- ג. נדרשת הדמיית מח בשל גילו.
- ד. יש צורך במנוחה קפדנית מכל פעולה פיזית ומוחית לפחות למשך שבוע.

26. בן 68, מזה 12 שנים מטופל בסוכרת וביתר לחץ דם. לחצי הדם מאוזנים תרופתית ביעד הרצוי. סוכרת – 7.5% HbA1C ואין עדות לפגיעה באברי מטרה. מקבל טיפול ב-Lipitor (Atorvastatin) במינון של 20 מ"ג ליום. במעבדה - פרופיל השומנים: LDL=128, Total Cholesterol=206, HDL=38, TG=200. על פי הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה (הנחיות קליניות 2021) מהי ההתייחסות הנכונה ביותר לפרופיל שומנים זה?

- א. להגביר את הטיפול בסטטין ובהעדר פגיעה באברי המטרה ניתן להסתפק ביעד איזון של LDL מתחת ל-100 מ"ג/ד"ל.
- ב. להוסיף טיפול בבזפיברטים כדי להוריד את ערכי הטריגליצרידים לערך של מתחת ל-150 מ"ג/ד"ל.
- ג. להגביר את חוזק הסטטינים ולשקול תוספת Ezetrol (Ezetimibe) על מנת להגיע ליעד איזון LDL מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל.
- ד. לבצע בדיקת Lipoprotein (a) (Lpa), ורק במידה והערך מעל 75 מ"ג/ד"ל להעלות את חוזק הטיפול בסטטינים ולשאוף לאיזון LDL מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל.

27. בת 68, מעשנת, ללא ניתוחי בטן בעברה.
מתלוננת מזה כחצי שנה על שלשול מימי (ללא דם או ריר), שאינו קשור לאכילת מזון מסוים. ללא כאב בטן. בדיקת צואה לדם סמוי שלילית, וקולונוסקופיה תקינה.
מהי האבחנה הסבירה ביותר?

- א. Microscopic colitis
- ב. Ulcerative colitis
- ג. Dumping syndrome
- ד. Carcinoma of colon

28. בן 75, מגיע עקב כתמים חומים באזור המצח בלבד שהופיעו לאחרונה.



מהי הסיבה הסבירה לכתמים?

- א. תת פעילות של בלוטת התריס.
- ב. סוכרת.
- ג. אי ספיקת כליות.
- ד. טיפול הורמנולי לסרטן ערמונית.

29. בן 42, בריא בד"כ, עובד כמכונאי, מתלונן על כאב באזור המרפק הימני מזה כחודשיים, הכאב מוחמר בתנועה ומקשה עליו בעבודה.

מהו הממצא שיכוון לאבחנה המתאימה ביותר?

א. רגישות על מוצא השריר Extensor Carpi Radialis Brevis תכוון לאבחנה של מרפק גולף – Medial Epicondylitis.

ב. צילום מרפק או US הכרחיים לאבחון Lateral Epicondylitis.

ג. מבחן chair lift חיובי אשר יפיק כאב בהרמת כיסא כשהמרפק ביישור, יכוון לבורסיטיס כרוני באולקרנון.

ד. הפקת כאב ביישור כף היד נגד התנגדות כאשר המרפק ביישור תכוון לאבחנה של מרפק טניס – Lateral Epicondylitis.

30. בן 90, סובל מדמנציה. בנו היחיד גר בצרפת והפעם האחרונה שביקר את אביו הייתה לפני 3 שנים.

מזה 4 שנים המטופל גר עם המטפל הזר המסור שלו והוא האדם הקרוב לו.

לפני 10 שנים המטופל חתם על הוראות מקדימות וביקש לא לבצע בו פעולות מאריכות חיים.

כעת חלה בקורונה ומצבו הנשימתי הדרדר. כאשר הרופא ביקש את רשותו לעבור להנשמה הוא ענה "תעשו מה שנדרש".

המטפל הזר השווה לידו טוען שהמטופל לא מעוניין שיאריכו את חייו.

לפי "חוק החולה הנוטה למות" מה מוטל על הרופא לעשות?

א. להישמע להמלצת המטפל כי הוא האדם הקרוב לו ולא להנשים את המטופל.

ב. לא להנשים את המטופל כי זה מה שחתם עליו ב"הוראות מקדימות" כאשר לא היה דמנטי.

ג. להנשים את המטופל, ההוראות המקדימות נכתבו לפני 10 שנים.

ד. ליצור קשר טלפוני עם בנו ולפעול בהתאם להחלטתו.

31. בן 65 עבר בירור עקב שני אירועים של עיוורון חולף בעין שמאל. האירועים נמשכו פחות משעה. בבדיקת רופא עיניים דחופה - קרקעית העין תקינה. דופלקס קרוטידים מראה היצרות של כ-60% בעורק הקרוטיס הפנימי משמאל ו-40% בעורק הקרוטיס הפנימי מימין. התחלת טיפול באספירין וסטטין. מהי הגישה הטיפולית הנכונה למטופל זה?

- א. ביצוע endarterectomy משמאל.
- ב. המשך טיפול שמרני.
- ג. ביצוע מעקף משמאל.
- ד. ביצוע endarterectomy דו צדדית.

32. בת 65 חדשה במרפאה. עצמאית, לא מעשנת. ללא תלונות. ברקע - יתר לחץ דם מאוזן תרופתית, סוכרת – מטופלת תרופתית, מאוזנת חלקית. עודף שומנים בדם - מטופלת בסטטין. BMI=32. מהי בדיקת הסקירה המומלצת עבור המטופלת?

- א. US סקירה למפרצת אאורטה בטנית.
- ב. צפיפות עצם.
- ג. אק"ג.
- ד. בדיקה במעבדת שינה.

33. בת 28, נשואה, ללא ילדים. מזה 3 חודשים עייפות, נוקשות בוקר מעל שעה וכאבים סימטריים בפרקי PIP (מצורפת תמונה). במעבדה: RF חיובי ושקיעת דם 60 לשעה.



מה מכוון את ההחלטה בבחירת הטיפול בקו ראשון?

- א. יש לנסות NSAIDs למשך 3 חודשים.
 - ב. במחלה קשה יש להעדיף Plaqueneil (Hydroxychloroquine) על פני Methotrexate.
 - ג. טיפול ב-Remicade (Infliximab) מעלה סיכון לזיהומים קשים ולכן אינו קו ראשון.
 - ד. מכיוון שהיא בגיל הפוריות עדיף להתחיל טיפול ב-Arava (Leflunomide).
34. בן 10 שנים, הסובל מ-Juvenile Idiopathic Arthritis-Oligoarthritic, מטופל ב-NSAIDs בעת ההחמרה, ללא צורך בטיפול נוסף. המחלה ברמיסיה כעת. בבדיקות הדם CRP מתחת ל-0.5, Antinuclear antibody (ANA) גבוה, Rheumatoid factor (RF) שלילי.
- מה המעקב התקופתי שהמטופל צריך לבצע?

- א. צילום חזה.
- ב. בדיקת עיניים (slit lamp examination).
- ג. בדיקת שתן כללית.
- ד. תפקודי בלוטת התריס.

35. בן 21, בריא בד"כ. אינו מעשן. בדיקה גופנית תקינה למעט מראה אצבעות ידיים כמתואר בתמונה. מתאר תמונה דומה גם אצל שני אחיו.



מה הברור הנדרש?

- א. ביצוע צילום חזה.
- ב. לשלוח 3 דגימות כיח לציטולוגיה.
- ג. ספירת דם, תפקודי תריס, טרנסאמינזות ובדיקה לצליאק.
- ד. ביצוע CT חזה מופחת קרינה.

36. בת 71, ברקע – יתר לחץ דם, אוסטיאוארטריטיס מפרקי הברכיים ושבר בשורש כף יד לאחר נפילה לפני 3 שנים.

בדיקת צפיפות עצם עדכנית: T SCORE בעמוד שדרה (-1.6), צוואר הירך (-0.8).
מה הצעד הבא במעקב וטיפול במקרה זה?

- א. תוצאה תקינה לגילה, יש לחזור על בדיקת צפיפות העצם עוד 5 שנים.
- ב. תוצאה גבולית, יש לחזור על הבדיקה בעוד שנה.
- ג. יש לתת כעת סידן וויטמין D ולחזור על הבדיקה בעוד שנתיים.
- ד. יש להתחיל טיפול נוגד ספיגת עצם.

37. בן 60 עבר קולונוסקופיה כבדיקת סקירה. הבדיקה תוארה כתקינה למעט סעיפים מרובים בקולון.
מהי ההמלצה למניעת סיבוכי הממצא המתואר?

- א. להימנע מאכילת פיצוחים, קטניות, תירס ופופקורן.
- ב. להרבות בתזונה עתירת סיבים.
- ג. טיפול ב-Senna או Laxadin (Bisacodyl).
- ד. להימנע מאכילת פירות כגון תפוז, אפרסמון וקוקוס.

38. בן 67, מטופל ב-Eliquis (Apixaban) בשל פרפור עליות. עישון כ-50 שנות חפיסה. בבדיקת שתן לכללית ממצא של 20 כדוריות דם אדומות לשדה הגדלה גדולה (RBC's /HPF). ללא ממצאים חריגים נוספים. לשאלתך הוא משיב כי הבדיקה נלקחה מאמצע זרם, אינו חווה כל תסמינים, לא ביצע פעילות גופנית ב-48 השעות לפני הבדיקה.
מהו המשך הברור המתאים ביותר?

- א. לשלוח בדיקת שתן למיקרוסקופיה.
- ב. אין צורך בברור נוסף עקב טיפול במדללי דם.
- ג. לבצע בדיקת שתן במקלון עוד פעמיים בחודש הקרוב.
- ד. לשלוח כעת שתן לציטולוגיה.

39. בת 60, לוקה בסוכרת. BMI 29. מטופלת ב-2X Glucophage (Metformin) ליום וב-5 Trajenta (Linagliptin) מ"ג ביום.
 במעבדה - בדיקת HbA1C = 8.5% וערך eGFR = 35 מל/דקה, ללא מיקרואלבומינוריה.
 מהו השינוי בטיפול המתאים לה ביותר?

- א. הפסקת טיפול Glucophage (Metformin) והתחלת טיפול באינסולין.
- ב. החלפת Trajenta ב-Januvia (Sitagliptin) במינון מרבי.
- ג. הפסקת Trajenta והוספת טיפול ב-Ozempic (Semaglutide).
- ד. הוספת טיפול ב-Ozempic (Semaglutide) לטיפול הנוכחי.

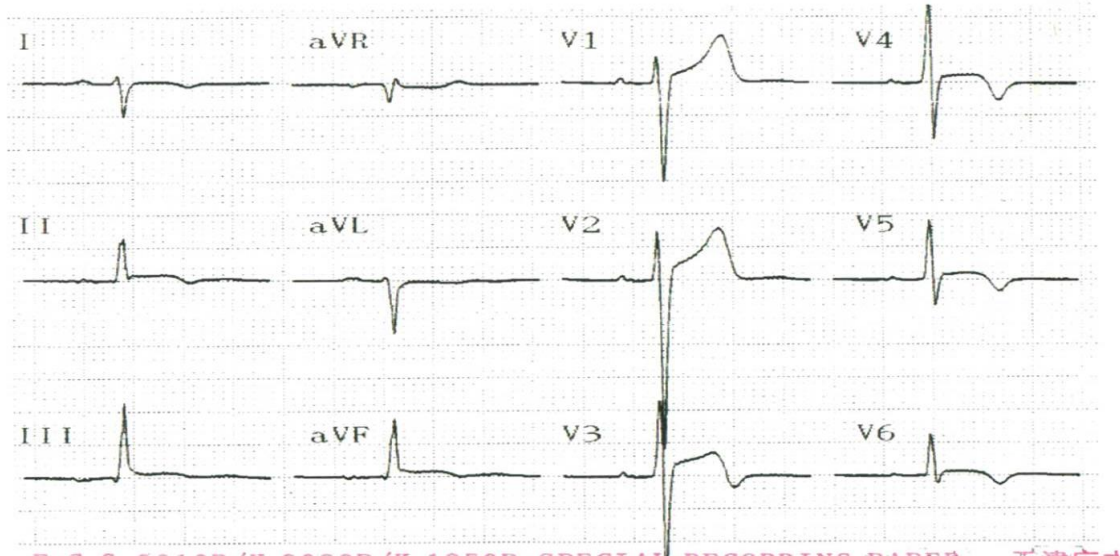
40. מה מבין הנתונים הבאים לגבי הומוסקסואליות נכון?

- א. השכיחות באוכלוסייה הכללית פחותה מ-1%.
- ב. זהו גורם סיכון להתאבדות, בעיקר בבנים.
- ג. טיפול התנהגותי בהומוסקסואליות הוכח כיעיל בשינוי הנטייה המינית.
- ד. ישנו קשר מוכח למגוון הפרעות פסיכולוגיות בבגרות.

41. מה מאפיין את מהלך רטינופתיה סוכרתית?

- א. הרטינופתיה מתפתחת מהר יותר ובשכיחות גבוהה יותר בסוכרת type 1 מאשר בסוכרת type 2.
- ב. במהלך הריון אצל חולת סוכרת נדיר שתפתח רטינופתיה לאור הגנת השינויים ההורמונליים על העין.
- ג. השגת יעד איזון של HbA1C מתחת ל-7% הוכחה כמאטה את התפתחות הרטינופתיה בסוכרת type 2, ולא בסוכרת type 1.
- ד. לאחר עשר שנים של סוכרת type 2 למרבית החולים תהיה רטינופתיה פרוליפרטיבית.

42. בן 25, בריא בדרך כלל, ב-4 ימים האחרונים מצונן. מהבוקר – חולשה כללית קיצונית, כאב בחזה קבוע, מתגבר בשאיפה עמוקה.
מוצג אק"ג של המטופל:



מהי בדיקת הבחירה לאבחון מחלתו של המטופל?

א. בדיקת דם לטרופונין.

ב. שקיעת דם.

ג. אקו לב.

ד. אנגיוגרפיה.

43. לפניך מספר מקרים עם עקמת, בהדמיה זווית העקמת היא בין 20-30 מעלות.
למי מהמקרים הסיכון הגבוה ביותר להחמרת העקמת וצורך בהתערבות?

א. בת 12, עדיין לא קיבלה מחזור וסת.

ב. בת 13, שנתיים לאחר קבלת מחזור הוסת.

ג. בן 17, השלים את ההתבגרות המינית שלו.

ד. בן 18, מתלונן על כאבי גב קלים.

44. אישה בהריון אובחנה כסובלת מתירטוקסיקוזיס מסוג Grave's Disease. מה הנכון לגבי אפשרות הטיפול?

- א. חוסמי ביטא אסורים לשימוש בהריון גם אם מדובר בטיפול קצר טווח של ימים ספורים להקלת תסמיני תירטוקסיקוזיס.
- ב. Methimazole הינו הטיפול המועדף לאורך כל ההריון.
- ג. Propylthiouracil הוא הטיפול המועדף לאורך כל ההריון.
- ד. הריון הינו התווית נגד לטיפול בIOD רדיואקטיבי בגלל החשש להצטברות שלו בבלוטת התריס של העובר.

45. בן 80, מזה כ-10 שנים מטופל ב-Dopicar (Levodopa+Carbidopa) עקב רעד ביד ימין במנוחה והליכה איטית בצעדים קטנים. כתב ידו הפך לקטן. לאחרונה הכי מפריע לו רעד בשתי ידיים כאשר אוחז בדברים כך שאינו מסוגל לשתות מכוס כי הכל נשפך. מהו הטיפול המתאים למצבו?

- א. העלת מינון Dopicar (Levodopa+Carbidopa).
- ב. הוספת טיפול ב-Depalept (Valproic Acid).
- ג. הוספת Primidone (Prysoline).
- ד. הוספת Valium (Assival).

46. בת 63, בריאה, BMI 28, מלינה על כאבים באזור העקב. כאב הכי חמור בתחילת הליכה, מוקל לאחר פעילות. ללא חבלה. מה אופייני לגבי האבחנה הסבירה?

- א. פלקסיה פלנטרית מחמירה את הכאב.
- ב. רגישות למישוש בקלקנאוס התחתון.
- ג. רפלקס אכילס מופחת.
- ד. השטחה של קשת מדיאלית של כף הרגל.

47. בן 40, בריא בד"כ, הגיע עם הממצא הבא (ראה תמונה מצורפת). לדבריו זה קרה די במהירות ללא גרד או תלונות אחרות.



מהו הטיפול המתאים ביותר במקרה זה?

א. Cr.Triamcinalone Acetonide

ב. Tab.Spiroinolactone

ג. Tab.Finasteride

ד. Shamp.Ketoconazole

48. בן 28, בריא, ללא טיפול קבוע, ממצא לוואי בבדיקת על קול שעבר - אבן באגן כליה בקוטר 3 מ"מ, ללא הידרונפרוזיס. לא סובל מתסמינים כלשהם. ללא רקע משפחתי של אבני כליות או אירועים של renal colic בעבר. איזה בירור יש לבצע?

א. השלמת בירור ע"י CT בטן פורטוקול אבנים.

ב. מיפוי DMSA.

ג. בירור מטבולי רחב של אבנים בדרכי שתן.

ד. מעקב על קול אחרי האבן לאחר חצי שנה ובהמשך מדי שנה.

49. בן 35, בריא בדרך כלל, מזה מספר ימים מנוזל. ביממה האחרונה החל כאב עז מלווה בירידה קלה בשמיעה באוזן ימין.

בבדיקה – חום 38.5 מעלות צלזיוס, באוטוסקופיה – בלט משמעותי של תופית מימין. המטופל נוטל Dexamol Cold.

מהו הטיפול המומלץ כעת?

א. טיפות מאלחשות לאוזן ימין (Otidin).

ב. טיפות Ciloxan (Ciprofloxacin).

ג. השהיית הטיפול ל-24-72 שעות והחלטה בהמשך לפי מצב קליני.

ד. Augmentin (Amoxycillin/Clavulanic Acid) פומי.

50. זוג הורים מודאגים לגבי בנם בן ה-14, נהנה ללבוש שמלות כשהוא בבית ולהתאפר. מספר פעמים הוא ביקש לצאת כך מהבית, אך הוריו סירבו בתוקף. יש לו רק חברות בנות בכיתה, ולא חברים בנים. הוא נמנע מכל פעילות אלימה, כגון חוג ג'ודו, או היאבקות עם חבריו לכתה. איזו הנחיה ניתן לתת להורים?

א. מדובר בתסמינים ראשוניים של הומוסקסואליות ועליהם לקבל זאת כעובדה.

ב. יש להפנותם למרכזי תמיכה מתאימים ל-gender-nonconforming child.

ג. אין קשר בין התנהגות זו לזהות מינית או מגדרית לאחר השלמת ההתבגרות המינית.

ד. התנהגות זו קשורה לחילופי תפקידים מסורתיים בין האב והאם במשפחה.

51. בת 3 חודשים, בריאה, התפתחות תקינה, מאז לידתה – דמעת קלה בשתי העיניים והפרשה מוגלתית לסירוגין בעיקר בעין ימין. מהו הטיפול המתאים ביותר?

א. לא נדרש טיפול, יחלוף ספונטני עד 6 חודשים.

ב. עיסוי מקומי 2-3 פעמים ביום.

ג. ניתוח כעת, בגילה לא צפויה החלמה ספונטנית.

ד. מומלץ טיפול אנטיביוטי פומי לשבועיים.

52. בן 57, עישון כבד של כ-30 שנות קופסא. מתלונן על שיעול עם כיח ותחושת קוצר נשימה מידי פעם, במיוחד במאמץ מזה מספר חודשים.

הוא לא אושפז מעולם בשל התלונה, וללא התלקחות בשנה האחרונה.

בתפקודי ריאה נמצא $FEV1/FVC = 0.58$.

בשאלון The COPD assessment test (CAT), הציון הוא 12.

ספירת הדם כולל דיפרנציאל תקינה.

מהו הטיפול המומלץ לשיפור מצבו?

א. SABA (Short-acting beta agonists)

ב. SAMA (Short-acting muscarinic antagonists)

ג. LABA (Long-acting muscarinic antagonists) או LABA (Long-acting beta agonists)

ד. LABA (Long-acting beta-agonist) עם ICS (Inhaled corticosteroids) בשילוב

53. בת 19, בשנה האחרונה ירדה 10 ק"ג במשקל, אל-וסת (אמנוריאה) מזה שלושה חודשים, ממשיכה בתפקוד יומיומי רגיל. בחשד קליני ל-Anorexia Nervosa מהו הבירור שיש לבצע בתחילת האבחנה?

א. הולטר אק"ג למשך 24 שעות.

ב. בדיקת צפיפות עצם.

ג. Prolactin, Estradiol, LH, FSH.

ד. העמסה של 75 גרם גלוקוז.

54. בן 45, מעשן קופסא וחצי ליום מגיל 20, ללא מחלות רקע וללא תלונות. מהי ההמלצה המתאימה ביותר לגבי בדיקת סקר לגילוי מוקדם של סרטן ריאות?

א. בגילו עדיין אין צורך בהתערבות לגילוי מוקדם.

ב. להפנותו לבצוע צילום חזה פעם בשנה.

ג. לבצע בדיקת CT חזה בקרינה נמוכה פעם בשנה.

ד. לשלוח כיח לציטולוגיה ובדיקת רופא ריאות אחת לשנה.

55. בן 65, עבר אירוע ראשון בחייו של פרכוס, ביצע בדיקת EEG שהייתה תקינה, מתקשה לקבל אבחנה של אפילפסיה ותוהה לגבי הבירור הנדרש והגורמים לאבחנה. מהו ההסבר המתאים ביותר?

- א. EEG תקין שולל אבחנה של אפילפסיה.
- ב. פרכוס שמתחיל מעל גיל 65 לרוב נגרם מגידול.
- ג. במבוגרים ב-40-25% מהמקרים לא ניתן למצוא את הגורם.
- ד. אין ערך אבחנתי נוסף לביצוע EEG בחסך שינה בחשד לאפילפסיה.

56. בת 53, ברקע - יתר לחץ דם, מטופלת ב-Tritace (Ramipril) ו-Eliquis (Apixaban) בשל DVT בצעירותה, שנה לאחר הפסקת הווסת. פונה עקב תלונות של גלי חום ויובש נרתיקי. מהו ההסבר המתאים ביותר למטופלת לגבי טיפול הורמונלי חלופי (HRT)?

- א. בגילאי 50-59, מיד לאחר המנופאוזה, הסיכון לתחלואה כגון מחלות קרדיו-וסקולריות, סרטן שד עקב הטיפול הינו הגבוה ביותר ולכן יש להימנע מטיפול בגילאים אלו.
- ב. DVT בעברה הינו התווית נגד (contraindication) ל-HRT ולכן יש להימנע מטיפול במקרה זה.
- ג. גלי חום חמורים אינם אינדיקציה לטיפול הורמונלי חלופי מכיוון שחולפים מעצמם לאחר מספר שנים.
- ד. יובש נרתיקי מגיב טוב יותר לטיפול הורמונלי סיסטמי ולכן יש להשתמש בטיפול הורמונלי סיסטמי על פני טיפול הורמונלי מקומי-נרתיקי.

57. מהו הטיפול היעיל ביותר לטווח הארוך בכתף קפואה?

- א. NSAIDS.
- ב. פרדניזון פומי.
- ג. טיפול ניתוחי.
- ד. פיזיותרפיה.

58. איזה סוג מכאבי הראש הבאים מעלה את הסיכון להתפתחות גלאוקומה פתוחת זווית?

א. Tension-type headache

ב. Migraine headache

ג. Cluster headache

ד. Chronic daily headache

59. בן 4 שנים ננשך בפניו על ידי חתול המשפחה בעת משחק, מובא לאחר 4 שעות למרפאה. בבדיקה - נקב קטן (puncture wound) על הלחי. מה הטיפול הנכון ביותר?

א. שטיפה בלחץ מוגבר וחבישה.

ב. הטריה של הפצע ושטיפה, תפירה לאחר 3-5 ימים.

ג. שטיפת הפצע וטיפול אנטיביוטי.

ד. שטיפה ותפירה מיידי.

60. במהלך חזרות לטקס סיום טירונות החייל התעלף אחרי מאמץ של 3 שעות. מדובר באירוע ראשון בחייו. החייל התעלף למשך מספר שניות והתעורר כשרגליו הורמו. על פי המידע שניתן בתיאור המקרה איזה בירור יש לעשות כעת?

א. אק"ג

ב. ספירת דם

ג. EEG

ד. אקו לב

61. מי מהבאים הוכח כיעיל ביותר בהפחתת הסיכון לפתח דמנציה?

- א. תזונה טבעונית (Vegan diet).
- ב. הליכה בקצב איטי כשעה וחצי לשבוע.
- ג. תוסף של Ginkgo biloba.
- ד. טיפול הורמונלי חלופי לנשים בגיל המעבר.

62. בת 81 עם היצרות אאורטלית קשה. לאור אירועים חוזרים של איבוד הכרה הומלץ על החלפת מסתם.

מהם ההבדלים בין החלפת מסתם בניתוח פתוח לעומת פרוצדורה TAVI?

- א. בחודש הראשון יש יותר סיכון לחלות באירוע מוחי לאחר TAVI מאשר בניתוח לב פתוח.
- ב. הסיכון לסבול מהפרעות הולכה דומה ב-TAVI ובניתוח לב פתוח.
- ג. הסיכון לפתח פרפור פרוזדורים גדול יותר לאחר ניתוח לב פתוח.
- ד. הסיכון להזדקקות לקוצב לב גבוה יותר לאחר ניתוח לב פתוח.

63. בן 10 חודשים, בריא בד"כ, סבל מחום עד 40 מ.צ. במשך 3 ימים וחלף. לאחר חלוף החום הופיעה תפרחת עורית (ראה תמונה). האם נבהלה מהופעת התפרחת והתחילה טיפול במוקסיפן. בבדיקתו ילד נינוח וחייכן, בדיקה גופנית תקינה למעט תפרחת מקולופולרית בבטן שנעלמת בלחיצה.



מהו הצעד הנכון מבחינה טיפולית?

- א. להמשיך טיפול במוקסיפן לעוד 6 ימים.
- ב. להחליף טיפול ממוקסיפן לאזניל.
- ג. להרגיע את האם ולהפסיק טיפול במוקסיפן.
- ד. טיפול אנטיהיסטמיני למשך 3 ימים.

64. אם לתינוק ראשון הגיעה מודאגת. חוששת מתסמונת "מוות בעריסה" - Sudden Infant Death. נולד בשבוע 37, משקל לידה 2700 גר', אפגר תקין. במשפחה האחייין שלה נפטר ממוות בעריסה. מהי ההמלצה המתאימה במקרה זה?

- א. להשכיב את התינוק לישון עם מוצץ.
- ב. לדחות את חיסון המחומשת הראשון לגיל חצי שנה.
- ג. לישון עם תינוק באותה מיטה.
- ד. להמליץ על מוניטור ביתי.

65. בת 76, ברקע השמנת יתר. סובלת מספר שנים מכאבים בברכיים על רקע אוסטאוארטריטיס (Osteoarthritis). עקב כאבים כמעט ואינה יוצאת מהבית. מהו הטיפול שיפחית את הכאב לטווח הארוך?

- א. הזרקה של גלוקוקורטיקואידים למפרק הברך.
- ב. ירידה במשקל ופעילות גופנית הכוללת הליכה ותרגילי מתיחה.
- ג. הזרקה של חומצה היאלורונית למפרק הברך.
- ד. שימוש במכשיר TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation).

66. כל המטופלות הבאות מטופלות ב-Levothyroxine עקב תת תריסיות. באיזה מקרה ההמלצה לשינוי מינון היא הנכונה ביותר?

- א. שבוע 6 להריון, $TSH=2.3$, יש להכפיל מינון.
- ב. שבוע 16 להריון, $TSH=2.2$, יש להפחית מינון.
- ג. לפני הריון $TSH=3$, יש להעלות מינון בכ-30%.
- ד. 6 שבועות לאחר לידה, $TSH=3$, יש להעלות מינון בכ-20%.

67. בת 28, בריאה בד"כ, בהריון שבוע 20. בן זוגה סובל מאירועים חוזרים של הרפס גניטלי. היא לא סבלה אף פעם מהרפס גניטלי ובבדיקות דם ללא נוגדנים ל-HSV. מהי ההמלצה המתאימה ביותר למטופלת זו?

- א. משבוע 36 להתחיל טיפול אנטי ויראלי פומי.
- ב. מטרימסטר שלישי יש להימנע מיחסי מין כלל.
- ג. יש להשתמש בג'ל Tenofovir בזמן קיום יחסי מין.
- ד. צריכה ללדת בניתוח קיסרי.

68. בן 3 שנים, סובל מחום ויציאות רכות, כעבור יומיים התקבלה תשובה של תרבית צואה. בשיחה חוזרת עם האם יש שיפור ניכר במצבו של הילד.
מהי הגישה הטיפולית הנכונה ביותר במקרה זה?

- א. SHIGELLA חיובית בתרבית צואה מחייבת קבלת טיפול אנטיביוטי ב-Azenil (Azithromycin) גם אם הילד ללא מחלות רקע ומרגיש טוב.
- ב. SHIGELLA חיובית בתרבית צואה מחייבת טיפול אנטיביוטי ב-Ciprodex (Ciprofloxacin).
- ג. SALMONELLA NON THYPHOIDAL חיובית בתרבית צואה לא מחייב קבלת טיפול אנטיביוטי במידה וילד מרגיש טוב ובלי מחלות רקע.
- ד. YERSINIA חיובית בתרבית צואה מחייבת קבלת טיפול אנטיביוטי ב-Azenil (Azithromycin).

69. בן 60, ברקע – סכרת, מטופל ב-2X Glucophage (Metformin) ליום. בבדיקה האחרונה HbA1C 7%. בבדיקת אקו לב נמצא מקטע פליטה (Ejection Fraction) 40%.
מהו המשך הטיפול המומלץ ביותר למניעת אשפוזים?

- א. ברמת איזון זו לא מומלץ לבצע שינוי בטיפול.
- ב. הוספת טיפול ב-Januvia (Sitagliptin).
- ג. הוסף טיפול ב-Avandia (Rosiglitazone).
- ד. הוסף טיפול ב-Forxiga (Dapagliflozin).

70. מטופל שלך הסובל מכאבי גב, מתקשר אליך למרפאה.
מתי יש לתעד את שיחת הטלפון בתיקו הרפואי של המטופל?

- א. כאשר המטופל מתקשר להביע כעס על כך שלא הפנית אותו לבדיקת CT.
- ב. כאשר המטופל מתקשר להביע כעס על אורתופד שלא הפנה אותו לבדיקת CT.
- ג. כאשר המטופל מתקשר ומתלונן על כאבי גב, ואתה ממליץ לחמם את האזור ולהשתמש במשככי כאבים OTC.
- ד. כאשר המטופל מתקשר לברר תשובת CT שעשה וה-CT תקין.

71. בן 13.5 - גובה 160 ס"מ, משקל 105 ק"ג, BMI 41 (אחוזון מעל 99%). לחץ דם 125/78 מ"מ"כ (אחוזון 95%). במעבדה - סוכר בצום 105. באנמנזה - שני ההורים ואח גדול עם השמנת יתר. מהו הטיפול המתאים ביותר לנער זה?

- א. יש להציע טיפול פרמקולוגי מידי במקביל לשינוי אורחות חיים.
- ב. במידה וגיל עצמות מעל 15 אפשר להציע ניתוח בריאטרי כעת.
- ג. ניתן לשקול טיפול ב-Glucomin (Metformin).
- ד. הדרכת הורים בלבד לגבי שינוי אורחות חיים אינה יעילה לעומת הדרכה משולבת של ההורים יחד עם הנער.

72. בת 35, בריאה ברקע, מזה שעתיים החלו באופן פתאומי כאב בחזה מלווה בדופק מואץ, קשיי נשימה והמופטיזיס. בדיקה גופנית תקינה. על פי Wells' Criteria מה מבסס את החשד לתסחיף ריאתי?

- א. דופק 90 לדקה.
- ב. סיפור משפחתי של קרישיות יתר.
- ג. הודג'קין לימפומה בילדות.
- ד. ניתוח קיסרי לפני 3.5 שבועות.

73. בת 45, בריאה בד"כ, ברקע שלוש לידות וגינוליות, פונה לאחר שאובחנה כסובלת מצניחה של שלפוחית השתן בדרגה 2. מהי ההמלצה הטיפולית המתאימה ביותר?

- א. תרגילי Kegel לחיזוק שרירי רצפת האגן יכולים לשפר את דרגת הצניחה של איברי האגן.
- ב. טיפול ב-pessary מתאים לדרגות צניחה 1-2 בלבד.
- ג. כ-30% מהנשים שמתופלות ב-pessary סובלות מ-bacterial vaginosis.
- ד. ירידה במשקל עשויה לשפר את דרגת הצניחה של איברי האגן.

74. לפניך תיאור של 4 ילדים ללא מחלות רקע.

למי מהם יש אינדיקציה חד משמעית ל-Tonsillectomy (כריתת שקדים)?

- א. בן 5, נוחר בלילה. בבדיקת שינה הוכח שסובל מתסמונת דום נשימה בשינה. בבדיקתו שקדים מוגדלים מאד.
- ב. בן 4, בשנה האחרונה 5 אירועים מוכחים של דלקת שקדים חידקית כשבכל פעם היה לו חום מעל 38 מ.צ.
- ג. בן 6, בשנה האחרונה 3 אירועים מוכחים של דלקת שקדים חידקית כשפעם אחת היה אבסס פריטונסילרי.
- ד. בן 5, לדברי האם בשנה האחרונה היו מעל 8 אירועים של דלקת גרון סימפטומטית אך רק ב-3 מהם נבדק במרפאה והוכח במשטח שיש חיידק.

75. בת 32, שחקנית כדורסל. לפני מספר ימים סובבה את הברך בעת משחק. בבדיקתה מסוגלת ללכת אבל צליעה משמעותית, תפליט קל בברך, רגישות סדק מדיאלי, טווחי תנועה שמורים, מבחן מגירה קדמי שלילי, מבחן יציבות צידית תקין.
מהי האבחנה הסבירה ואיזו בדיקה יש לבצע?

- א. קרע ACL, יש להפנותה ל-MRI ברך.
- ב. לא ניתן להעריך מהבדיקה לכן יש לבצע צילום לשלילת שבר.
- ג. קרע רצועה קולטרלית, בדיקת US ברך.
- ד. קרע מניסוקס, הפניה לבדיקה במרפאה אורתופדית.

76. בת 75 מלינה על כאב בירך שמאל מזה כשנה. בחודשיים האחרונים החמרה בכאב לעוצמה של 8 מתוך 10. במעבדה (ALP) Alkaline phosphatase מוגבר ובצילום מודגמת התעבות וסקלרוזיס בעצם האגן משמאל עם אזורים ליטיים ודה-קלציפיקציה (decalcification). מהו הטיפול המומלץ לאבחנה הכי סבירה?

- א. סידן + ויטמין D.
- ב. Fosalan (Alendronic acid).
- ג. Forteo (Teriparatide).
- ד. סטרואידים.

77. מהי הסיבה השכיחה ביותר בילדים ל-gross hematuria?

- א. זיהום דרכי השתן.
- ב. IgA Nephropathy.
- ג. מחלה גלומרלרית.
- ד. Alport Syndrome.

78. בן 50 מתלונן על עיוות של בהונות 2-4 בכף רגל ימין שהתפתח במשך שנים, הגורם לו לכאב ואי נוחות בבסיס הבהונות. בבדיקה - בבהונות אלו מפרקי ה-MTP באקסטנציה קבועה (ריגידית), מפרקי ה-PIP בפלקציה קבועה (ריגידית) ומפרקי ה-DIP באקסטנציה. קיימת רגישות ניכרת באזור בסיס בהונות אלו.

איזה טיפול מקובל לבעיה זו בשלב זה?

- א. מדרס הגבהה לעצמות המטאטרזליות.
- ב. הזרקת סטרואידים מקומית.
- ג. סד קיבוע קשיח לבהונות.
- ד. תיקון ניתוחי.

79. בת 8 מתלוננת על תפרחת עורית (ראה תמונה מצורפת) שהופיעה לפני 3 ימים, מלווה בכאבי מפרקים, כאבי ראש, כאבי בטן ושלשול.



איזה ממצא מהבאים סביר שיימצא בבדיקתה?

- א. תפליטים דו"צ על גבי השקדים.
- ב. הארכת מקטע PR באק"ג.
- ג. דם בשתן (Hematuria).
- ד. Sydenham chorea.

80. בן 82, אלמן, מתגורר עם בנו. עבר קטיעת רגל שמאל מתחת לברך בעקבות רגל סוכרתית. סובל מירידה קוגניטיבית.

שוחרר לאחר אשפוז בשל ספסיס שמקורו בזיהום ברגל השנייה. אינו רוכש תרופות בסדירות בשנתיים האחרונות ולא מגיע למעקבים ובדיקות במרפאה.

רופא המשפחה הגיע לביקור בית לאחר האשפוז אולם הבן סרב להכניס אותו לבית.

מה חובה על רופא המשפחה לעשות?

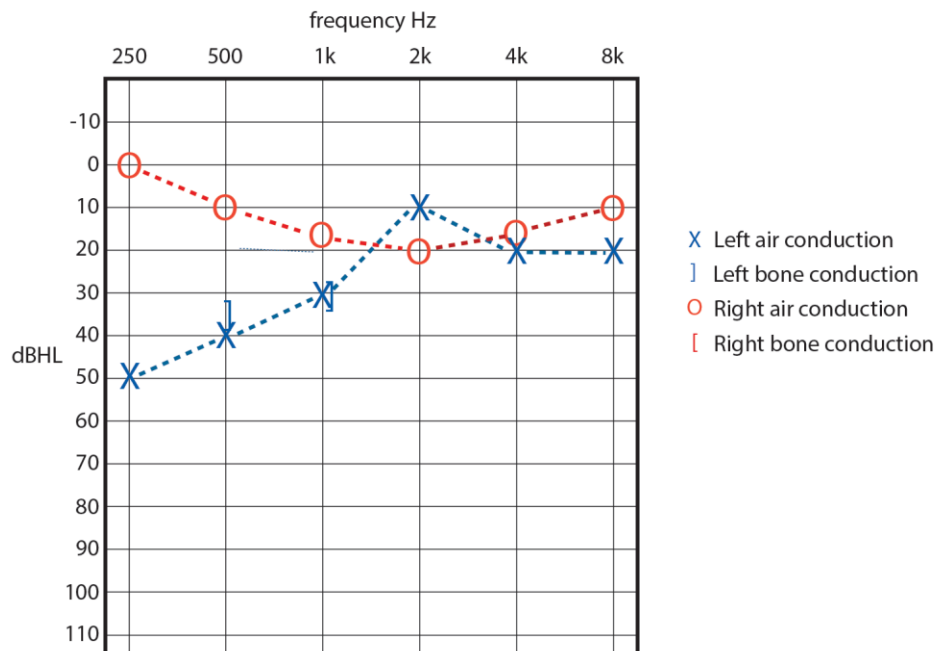
א. לשוב לבדיקה ולקבוע את כשירות המטופל לקבל החלטות.

ב. לדווח על המקרה לניהול סיכונים.

ג. לדווח על המקרה לעובדת הסוציאלית של המרפאה.

ד. לדווח על המקרה לפקיד סעד.

81. בת 50, מתלוננת על תחושת מלאות באוזן שמאל, סחרחורת וטינטון. התלונות הופיעו בפתאומיות מאתמול. לפני כחודשיים היו תסמינים דומים שחלפו מעצמם תוך מספר שעות. בבדיקת השמיעה:



מהו הטיפול בבעיה זו?

- א. הגבלת מלח בתזונה, 250 Acetazolamide (Diamox) מ"ג 2X ביום.
- ב. הפניה לייעוץ אא"ג כדי לשקול ניתוח של האוזן התיכונה.
- ג. הפניה לניקוי שעווה (Cerumen) ע"י רופא/ת אא"ג.
- ד. הפניה לרפואה תעסוקתית לצמצום חשיפה לרעש במקום העבודה.

82. בת 40, במהלך הריון בעקבות תלונות של הזעות ליליות וממצא של בלוטות לימפה מוגדלות בשני בתי השחי, הופנתה לבירור.
 במעבדה: שקיעת דם 70/שעה.
 בדיקת PET: קליטה מוגברת של בלוטות לימפה בשתי הזרועות ללא מעורבות אתרים נוספים. בביופסיה אובחנה Hodgkin's Lymphoma.
 מה מהבאים מהווה גורם פרוגנוסטי רע?

- א. גיל המטופלת.
- ב. מספר אזורי בלוטות הלימפה המעורבים.
- ג. התייצגות עם הזעות לילה.
- ד. הריון המטופלת.

83. בת 19 מגיעה למרפאה עם תלונות על נפיחות בפנים ובצקת ברגליים. בבדיקה גופנית לחץ דם גבוה ונגעים עוריים (ראה תמונה). בדיקת שתן: RBC +++, חלבון +++. שתן במיקרוסקופ: תאי RBC דיסמורפיים ובגלילים (casts).



מהו הצעד הבא לצורך הגעה לאבחנה?

- א. מעבדה ל-ANA, רמות C3, C4, anti ds-DNA.
- ב. ביופסיית כליה.
- ג. US כליות.
- ד. בדיקת סרולוגיה לאמביאזיס.

84. את מי מהבאים יש לשלוח לצילום חזה?

- א. בת 4, בריאה בד"כ. לפני חצי שנה אושפזה עקב דלקת ריאות וטופלה בהתאם. מאתמול חום 39, משתעלת מנוזלת, בבדיקתה - לא מתנשמת, סטורציה תקינה, בהאזנה - חרחורים.
- ב. בן 5, בריא בד"כ. יומיים חום 39, משתעל, מנוזל ומתלונן על כאבי בטן. בבדיקתו - סטורציה תקינה, בהאזנה - ריאות נקיות, בטן – רכה, לא רגישה.
- ג. בת 6, אתמול אובחנה ע"י רופא אחר עם דלקת ריאות והחלה לקבל מוקסיפן במינון המתאים. היום מגיעה עקב המשך החום עד 39, שיעול נזלת. בהאזנה - קרפיטציות משמאל.
- ד. בן שנה, ברקע פגות עם RDS (Respiratory Distress Syndrome). התפתחות תקינה, מחוסן כפי גילו. מאתמול חום 39, מנוזל ומשתעל, אוכל היטב. בבדיקה - אינו מתנשם, סטורציה תקינה, בהאזנה - חרחורים מרובים.

85. בן 42 פנה בשל כאבי גב תחתון מזה 3 ימים.

איזה נתון מצריך ביצוע הדמיה בשלב זה?

- א. כאב מתעורר בעקבות הרמת משא, הגבלה בטווחי תנועת עמוד שדרה עקב כאבים.
- ב. הכאב מקרין לרגל הימנית, מלווה בפרסטזיה, SLR חיובי מימין.
- ג. ניתוח לעמוד שדרה לפני 10 חודשים עם רגישות ממוקמת על פני חוליה.
- ד. מתעמל באתלטיקה, הכאב מוחמר באקסטנציה של הגב.

86. מה מאפיין שרירני רחם?

- א. רוב השרירנים נסוגים בגודלם לפני המנופאזה.
- ב. הגידול השפיר הנפוץ ביותר בנשים בגיל הפוריות.
- ג. הסיכון להתפתחות Leiomyosarcoma הינו 5%.
- ד. רוב השרירנים מופיעים לאחר המנופאזה.

87. בת 15, סובלת מאקנה שמפריע לה מאד. לפני כחודש החלה להשתמש ב-Benzoyl Peroxide מקומי ומצבה לא השתפר.

מהי ההמלצה הטיפולית המתאימה ביותר עבורה?

- א. הטיפול המקומי לא עזר, יש להחליף את הטיפול לאנטיביוטיקה מקומית.
- ב. לטפל ב-Minocycline 200 מ"ג בשילוב עם רטינואיד מקומי במשך 3 חודשים ואז לרדת בהדרגה במינון.
- ג. הטיפול המתאים הוא Minocycline 200 מ"ג למשך 6 חודשים על מנת להשיג תגובה לטיפול.
- ד. יש חשיבות להתחלה מוקדמת של טיפול אנטיביוטי סיסטמי למנוע היווצרות צלקות.

88. מהו הטיפול הראשוני המומלץ ל-Hordeolum?

- א. קומפרסים חמים ומשחה אנטיביוטית מקומית.
- ב. משחה אנטיביוטית מקומית וטיפול אנטיביוטי פומי.
- ג. קומפרסים חמים וטיפול אנטיביוטי פומי.
- ד. קומפרסים קרים, ובהמשך קומפרסים חמים.

89. בן 65, ברקע - סכיזופרניה. הבן מדווח שלאחרונה האב מתנהג בחשדנות כלפי השכנים בבניין, חושב שמנסים להרעיל אותו ולכן חושש לאכול, דופק וצווק על דלתות השכנים, מפחיד אותם ומבהיל את ילדיהם. הצעת לאב לפנות לבדיקה פסיכיאטרית והוא סירב להיבדק בידי פסיכיאטר. כיצד יש לפעול כעת?

- א. למנות אפוטרופוס לענייני גוף.
- ב. לפנות לפסיכיאטר מחוזי להוצאת הוראה לבדיקה כפויה.
- ג. לפנות לפסיכיאטר מחוזי להוצאת הוראה לאשפוז כפוי.
- ד. לפנות לרווחה לביקור בית דחוף של עו"ס.

90. מה נכון לגבי ביטוח בריאות ממלכתי?

- א. כל מי שנולד בישראל זכאי לשירותי בריאות.
- ב. כל תושב שמלאו לו 18 שנים חייב להירשם כחבר קופת חולים לפי בחירתו.
- ג. כל מבוטח זכאי לקבל באמצעות קופ"ח בה הוא חבר חלק מהשירותים הקבועים בסל.
- ד. קופת החולים יכולה להגביל או לשלול זכותו של המבוטח לפנות לערכאות.

91. בן 60, לדבריו בריא לחלוטין, ללא כל טיפול תרופתי ופעיל בד"כ הבחין בתפרחת חדשה (מצורפת תמונה).



בידיו בדיקת HIV שלילית מהחודש האחרון. מצורף צילום חזה שבוצע.



מה נדרש לשם ביסוס האבחנה?

- א. צילום ותפרחת עורית מספקים לקביעת האבחנה.
- ב. ביופסיית עור.
- ג. פאנל ראומטי.
- ד. CT חזה.

92. בת 50, בבדיקת דם שגרתית נמצא המוגלובין % 16 גרם. רמת אריטרופאיטין בדם נמצאה נמוכה. מה מבין הממצאים הבאים צפוי להימצא במטופלת הזאת?

- א. סטורצית החמצן באוויר החדר 85%.
- ב. באקו לב מודגם Rt to Lt Shunt.
- ג. יחס Urea ל-Creatinine יותר מ-20.
- ד. Megakaryocytes גדולים במשטח דם וטרומבוציטוזיס.

93. באילו תסמינים של גיל המעבר טיפול הורמונלי חלופי פומי יעיל?

- א. ירידה בחשק המיני.
- ב. הפרעה בשינה.
- ג. ירידה קוגניטיבית.
- ד. אי שליטה בשתן.

94. מהי ההמלצה לגבי מניעת עששת בילדים?

- א. צמצום שתייה ממותקת ובמידה ושותים עדיף שתייה איטית מבקבוק.
- ב. מניעת עששת בשיני חלב לא תמנע עששת בשיניים קבועות.
- ג. להקפיד על שימוש בתכשירי פלואוריד.
- ד. לעודד צחצוח שיניים עצמאי מגיל הגן.

95. בן 55, ברקע - סכרת, יתר לחץ דם ואי ספיקת כליות כרונית. מטופל זמן רב ב-Tritace (Ramipril) 5 מ"ג פעמיים ביום ו-Metformin 850 מ"ג פעמיים ביום. ל"ד בבדיקות חוזרות 150/95 מ"מ"כ, דופק 90 לדקה. BMI 27. במעבדה: eGFR 48, אשלגן 5.5, HbA1C 6.8%. מהו הטיפול התרופתי המתאים ביותר?

- א. הוספת טיפול ב-Thiazide.
- ב. הוספת טיפול ב-Semaglutide.
- ג. הפסקת Metformin.
- ד. הוספת טיפול ב-Bisoprolol.

96. בן 78, ברקע – יתר לחץ דם לא מאוזן, מדידות חוזרות 170/95 מ"מ"כ. הגיע כעת בהתקף גאווט בקרסול ימין.

מה הטיפול המומלץ ביותר?

א. Ibuprofen.

ב. Colchicine.

ג. Prednisone.

ד. Allopurinol.

97. בת 37, בריאה בד"כ, מתלוננת על כאבים בצוואר שהחלו יום לאחר תאונת דרכים קלה שבה רכב פגע ברכבה פגיעה אחורית קלה. ללא פגיעה ישירה בראש/צוואר. הכאב הופיע רק מספר שעות לאחר התאונה בהדרגה. פרט לכאבים חשה בטוב. בבדיקתה ללא רגישות במישוש על פני חוליות עמ"ש, רגישות למישוש בשריר הטרפז, הגבלה קלה בטווחי תנועה של הצוואר על רקע כאבים, ללא חסרים נוירולוגים בגפיים.

מהי ההמלצה המתאימה ביותר לגבי הטיפול והפרוגנוזה?

א. ללא טיפול מרבית המטופלים יסבלו מכאבים כרוניים.

ב. מומלץ שימוש בצווארון לקיבוע והפחתת התנועה בצוואר לשבוע.

ג. לאנלגטיקה נרקוטית אין יתרון על פני נוגדי כאב אחרים בטיפול בכאבי צוואר.

ד. פיזיותרפיה אינה מומלצת בהקשר של כאבי צוואר מחשש לפגיעה בעמוד שדרה צווארי.

98. בן 54, אתמול ביצע עבודות ריתוך מתכת וניקוי מרזבים, לאחר מספר שעות החל להרגיש צריבה ותחושת חול בשתי העיניים, מתקשה מעט לראות.

בבדיקה – אודם בולט בלחמיות, אישונים שווים מגיבים לאור, תנועות עיניים תקינות.

מהו הטיפול המתאים ביותר במקרה זה?

א. הפנייה למיון עיניים בחשד לגוף זר.

ב. מתן טיפות Localin (local anesthetics) לעיניים בחשד לכוויה.

ג. הפנייה לרופא עיניים בחשד לגלאוקומה.

ד. מתן Cromoptic (Sodium Cromoglycate) לדלקת אלרגית.

99. בן 5, מזה 3 ימים מתלונן על כאב בפה, עליית חום סיסטמי בערבים עד 40 מעלות צלזיוס, אינו אוכל ושותה בגלל הכאב. בדיקתו גופנית תקינה פרט לממצאים בחלל הפה (ראה תמונה מצורפת).



מהו הטיפול המומלץ ביותר?

- א. 5 פעמים ביום לשבוע. PO Acyclovir 15 mg/kg.
 - ב. 3 פעמים ביום לשבוע. Oint.Oracort E (Triamcinolone+Lidocaine).
 - ג. 20mg PO Prednisone פעם ביום לשבוע.
 - ד. 3 פעמים ביום לשבוע. IV Acyclovir 30mg/kg.
100. בן 45, בריא בד"כ, מתלונן על קושי בשינה בלילה עקב תחושות לא נעימות ברגליים וצורך להזיז אותן. כשהוא קם מהמיטה ומתנועע התחושות חולפות. מהי ההמלצה המתאימה בשלב זה?

- א. שתיית כוס יין אדום לפני השינה.
- ב. ניסיון טיפולי עם Cipralex (Escitalopram).
- ג. הליכה קצרה לפני השינה.
- ד. ניסיון טיפולי עם מתן ויטמין B12.

101. בת 25, נשואה ללא ילדים, בריאה בד"כ. בהריון בשבוע 14, מזה כשלושה חודשים מציינת קשיי הירדמות, מרגישה עייפה במהלך היום למחרת. מקפידה על היגיינת שינה. טיפול CBT לשינה שבוצע לאחרונה לא הביא להטבה.

מהי התרופה המועדפת כטיפול לאינסומניה במקרה זה?

א. Doxylamine (Tonight)

ב. Diazepam (Assival)

ג. Zolpidem

ד. Melatonin

102. בת 5, לדברי ההורים סובלת מעיכוב בדיבור. בבדיקתה שיתוף פעולה חלקי, תגובה חלקית ואיטית לפקודות, קשר עין ירוד והבעת פנים מינימלית.

מהי הבדיקה המומלצת לבירור הראשוני במצב זה?

א. בדיקת Chromosomal microarray (CMA).

ב. בדיקה למחלות מטבוליות.

ג. EEG.

ד. בדיקת ראייה.

103. בן 34, בריא בד"כ, מגיע עם כאב, אודם ונפיחות בברך שמאל שהחל מהלילה, פעם ראשונה בחייו.

שולל טראומה. מציין שצורך משקאות קלים ובירות בכמות גבוהה. בבדיקה: חום 38.0 מ.צ., BMI 30.

ברך שמאל נפוחה, אדומה, רגישה במישוש עם תפליט והגבלה בתנועת המפרק.

מהי הגישה המתאימה ביותר בשלב זה?

א. ניקור הברך.

ב. בדיקת סונר לברך.

ג. בדיקת רמת ח' אורית.

ד. בדיקת שתן ל-STD.

104. בן 38, בריא בד"כ, מתלונן על קושי בנשימה, שיעול, חום עד 39.5 מ.צ. מזה יומיים. בבדיקתו לחץ דם 88/58 מ"מ"כ, דופק 102 לדקה, סטורציה 89% באוויר חדר, 32 נשימות לדקה.

מהו הטיפול המועדף במקרה זה?

- א. צילום חזה וטיפול ב-Tamiflu (Oseltamivir).
- ב. להפנות להערכה במיון ושקילת טיפול באשפוז.
- ג. צילום חזה וטיפול אנטיביוטי ב-Moxypen (Amoxacillin) במינון גבוה.
- ד. טיפול באינהלציות עד 3 פעמים ביום ו-Prednisone 60 מ"ג ליום לשבוע.

105. בן 65, ברקע - יתר לחץ דם, מטופל ב-Disothiazide 12.5 מ"ג. במדידת לחץ דם שגרית במרפאה לחץ דם 190/100 מ"מ"כ. שולל כאב ראש, טשטוש ראייה, תופעות נוירולוגיות, כאבים בחזה, קוצר נשימה. בבדיקתו הגופנית תקינה, אק"ג תקין.

מה נכון לעשות כעת?

- א. אשפוז לאיזון יתר לחץ דם.
- ב. Tritace (Ramipril) 5 מ"ג ואמתין עד של"ד ירד ל-150/90.
- ג. Capoten (Captopril) תת לשוני חוזרים עד של"ד ירד ל-110/70.
- ד. אוסיף תרופה ללחץ דם ואזמין למעקב.

106. בת 7, בריאה, לא מחוסנת, שיחקה עם חבר אשר לאחר יומיים התגלה כחולה באבעבועות רוח. אמה שואלת לגבי סיכויי ההדבקה ואופן הטיפול.

מהי ההמלצה המתאימה ביותר?

- א. מומלץ לחסן את הבת תוך 5 ימים מהחשיפה.
- ב. לתת טיפול ב-Acyclovir 20 מ"ג/ק"ג 4X ליום למשך 5 ימים.
- ג. במקרה של הדבקה יש להתחיל טיפול ב-Acyclovir.
- ד. הסיכון להדבקה יומיים לפני הופעת המחלה אצל החבר מאד נמוך.

107. בת 41, נשואה עם 5 ילדים. ברקע - יתר לחץ דם מטופל תרופתית. סובלת מאירועים חוזרים של מיגרנה עם אאורה. לאחרונה הוצא התקן תוך רחמי מסוג NOVA (Copper IUD) עקב דימומים קשים מהו אמצעי המניעה הכי מתאים למטופלת זו?

- א. גלולות Yasmin (Ethinyl estradiol + drospirenone).
- ב. טבעת הורמונלית NuvaRing (Ethinyl estradiol + Estrogestrel).
- ג. מדבקות Evra (Norelgestromin + Ethinyestradiol).
- ד. IUD מסוג Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine system).

108. בן 85, צלול בדעתו, מרותק לכיסא גלגלים לאחר שבץ מוחי. המטופל מתגורר בביתו עם עובד זר לאורך כל שעות היממה. במהלך הביקור העובד הזר מדווח שהמטופל ירד במשקל – כ-5 ק"ג ב-4 החודשים האחרונים. בבירור נוסף מסתבר כי ילדיו של המטופל אחראים על התקציב עבור מזונות, ולא תמיד ניתן סכום מספק לקניית מצרכי מזון. כיצד יש לנהוג במקרה זה?

- א. מכיוון שאינו חסר ישע, חלה חובת יידוע בלבד.
- ב. מכיוון שמתגורר עם אדם בוגר וכשיר – אין צורך לבצע התערבות במצב.
- ג. מכיוון שחסר ישע חלה חובת דיווח למשטרה או פקיד סעד.
- ד. חובה על הרופא לשוחח עם ילדיו טרם פנייה לגורמים נוספים.

109. בן 65 מעשן כרוני, מטופל עקב יתר לחץ דם. מלין על כאבי בטן מרכזיים-אפיגסטריים מזה כחודש. הכאב מוחמר כשעה לאחר ארוחות. ירד במשקל כ-2 ק"ג עקב חשש מאכילה. מהבוקר מתאר החמרה של הכאב גם ללא קשר לאוכל. בבדיקתו - בטן מעט רגישה פרי-אומבליקלית ללא סימני גירוי צפקי, בהאזנה ניע מופחת. מי מבין הבדיקות הבאות מתאימה לברור האבחנה הסבירה ביותר?

- א. CT בטן עם חומר ניגוד.
- ב. תבחין נשיפה לנוכחות הליקובקטר פילורי.
- ג. בדיקת מעבדה למדדי דלקת, צליאק וגנטיקה ל-FMF.
- ד. סונר בטן.

110. למי מהבאים נדרש המשך בירור כעת?

- א. בן 13 עם חום 4 ימים ובלוטת לימפה בגודל 1.1 ס"מ צווארית קדמית מימין.
- ב. בת 15 עם מספר בלוטות לימפה מעל עצם הבריח ימין, הגדולה מבניהן 1.2 ס"מ, שבוע לאחר שגילחה שערות בבתי שחי.
- ג. בן 5 שנים, מנוזל ומשתעל שבוע, מספר בלוטות לימפה תת לסתיות משני הצדדים.
- ד. בת 17, מקוררת ומנוזלת עם בלוטות לימפה מרובות קטנות עד 0.5 ס"מ בבית שחי ימין.

111. בן 30 פנה עקב נפיחות בפי הטבעת. מצ"ב תמונה של בדיקתו:



מהו הטיפול המתאים ביותר במצב זה?

- א. אמבטיות SITZ בליווי תוספת סיבים בתזונה.
- ב. ניקוז הטרומבوزה בהקדם.
- ג. מניעת עצירות ופיזיותרפיה של רצפת אגן.
- ד. תיקון ניתוחי בגישה ביטנית.

112. בן 52, אשתו מתלוננת על שינוי בהתנהגותו לאחרונה. יש לו התקפי כעס שמעולם לא היו בעבר, הוא נראה "מרוחק" וחסר אמפתיה לצרכים שלה ושל הילדים, מזניח את עצמו וממעט להתקלח. בנוסף מתרשמת שלא מצליח להתרכז ולהשלים משימות הקשורות בעבודתו. שוללת סיפור משפחתי של דמנציה.

מהי האבחנה המתאימה ביותר למצב המתואר?

- א. Alzheimer's disease
- ב. Adult onset ADHD
- ג. Frontotemporal dementia
- ד. Normal pressure hydrocephalus

113. בן 62, מאובחן עם Lt. Ant. Tibial Vein Thrombosis לאחר חבלה. מהי ההחלטה המתאימה ביותר בשלב זה?

- א. בדיקת D-dimer וטיפול בהתאם.
- ב. 1 Clexan (Enoxaparine) מ"ג/ק"ג פעמיים ביום ל-3 חודשים.
- ג. Coumadin (Warfarin) עם שמירה על INR 2-3.
- ד. על קול דופלר חוזר בעוד מספר ימים לרגל שמאל.

114. בן 4.5 שנים, בריא בד"כ. הוריו מתנגדי חיסונים. הובא למרפאה כיוון שמסרב לאכול וחום גופו 39.5 מ.צ. בבדיקתו - הילד באי שקט, מרייר, ראשו מוטה אחורנית. מהו הטיפול?

- א. הורדת חום ומתן Rocephin (Ceftriaxone) תוך שרירי.
- ב. ייעוץ דחוף של אא"ג במרפאה בשאלה של אבצס רטרופרינגיאלי.
- ג. פינוי מידי באמבולנס תוך שמירה על דרכי אוויר.
- ד. ביצוע משטח גרון וטיפול ב-Amoxicillin פומי.

115. בת 30, בריאה בד"כ, הריון שבוע 33. בעברה לידה תקינה בשבוע 39. בבדיקתה - ל"ד 165/105 ממ"כ במספר מדידות, ללא בצקות. ספירת דם תקינה, תפקודי כבד וכליות תקינים ואיסוף שתן לחלבון תקין.

מהו הטיפול המתאים ביותר?

א. דיאטה דלת מלח והגבלת נוזלים.

ב. Trandate (Labetolol).

ג. Enaladex (Enalapril).

ד. Disothiazide.

116. באיזה מהמצבים הבאים ניתן לתת למטופל שלך תעודת מחלה ללא ביקור במרפאתה?

א. מטופל שבשיחת טלפון מוסר על שלשולים בשבוע האחרון, מבקש אישור מחלה על שבוע.

ב. מטופל שלפני כחודשיים סבל מחום במשך 3 ימים ושכח לבקש אישור מחלה.

ג. מטופל שלפני כשבועיים נבדק ע"י רופא מחליף בגלל טונסיליטיס וטופל ברפאפן, מבקש אישור מחלה על שבועיים.

ד. מטופל שלפני חודש נבדק במיון בגלל שבר ברגל, לא נרשמה המלצה לחופשת מחלה, מבקש אישור מחלה על 26 יום.

117. בן 37, ספורטאי, בחודשיים האחרונים מתאמן בריצה והעלה עוצמת אימונים וריצות. מלין על כאב אחורי בעקב, בבדיקה - רגישות באספקט האחורי של הקרסול, כאב מוחמר בדורסיפלקציה פאסיבית. אילו מהטיפולים הבאים נמצאו יעילים לבעיה המתוארת?

א. הזרקת Platelet rich plasma.

ב. קינזיוטייפינג (Kinesiology taping).

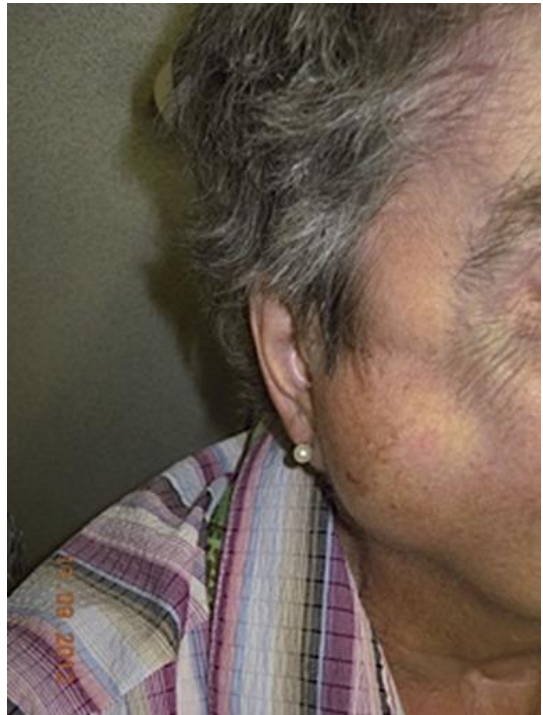
ג. הזרקת סטרואידים.

ד. הורדת לחץ מקומית ומנוחה.

118. בת 46, עד לפני שנה מחזורים סדירים, כעת מזה שנה ללא מחזור וסת.
מה נדרש לשם אבחון Menopause (הפסקת המחזור החודשי) באשה זו?

- א. אין צורך בבירור הורמונלי די בסיפור הקליני.
- ב. רמה נמוכה של ערכי FSH.
- ג. רמה מוגברת (Anti-Mullerian Hormone) AMH.
- ד. ערכים מוגברים של פרוגסטרון.

119. בת 82, כשבוע לאחר ניתוח בטן, מלינה על נפיחות בפנים, כאבים וקושי באכילה. בבדיקתה - חום 37.8 מ.צ., נפיחות באזור לחי מימין (מצורפת תמונה), רגישות במישוש, בבדיקת הפה חשד ליציאת מוגלה מפתח בלוטת הרוק מימין.



מהו הטיפול המומלץ במצב זה?

- א. NSAIDS, קומפרסים קרים והימנעות מעישון.
- ב. אנטיביוטיקה, סוכריות חמוצות ללא סוכר, קומפרסים חמים והידרציה.
- ג. קומפרסים חמים וניקוז המוגלה ע"י רופא שיניים.
- ד. אנטיביוטיקה בלבד עם כיסוי לפלורה של חלל הפה.

120. בת 28, נשואה אם לילדה בת שבוע, הגיעה לביקורת לאחר הלידה. בבדיקה אתה מתרשם שהאם מסויגת מהתינוקת. התינוקת בוכה ולאם לוקח זמן רב לשים לב אליה. האם מדווחת על תיאבון תקין ומצב רוח תקין. הרושם שלך כי לאם יש בעיה בהיקשרות לתינוקת.
מה מהבאים בהיסטוריה של האם מוכר כגורם סיכון לקושי בהיקשרות (attachment) עם יילוד על פי Dixon SD, Stein MT?

א. האם עובדת בהייטק בתפקיד ניהולי.

ב. לידה בניתוח קיסרי בשבוע 38 עקב מצג עכוז.

ג. לידת פג בשבוע 30.

ד. חוסר יכולת להניק.

121. בן 27, מטופל ב-Disothiazide וב-Remotive (Hyperticum Perforatum). קיבל בילדות את כל חיסוני השגרה. חיסון טטנוס אחרון לפני 7 שנים. פנה יום לאחר שהייה בים בה נכווה בכל הגב. בבדיקתו - שלפוחיות בגב, אודם ניכר וכאב.
מהו ההסבר והטיפול המומלץ?

א. אין צורך בחיסון טטנוס משום שחוסן ב-10 שנים אחרונות ובילדות.

ב. צריך להדריכו שהתרופות שנוטל תורמות לפוטוסנסטיביות.

ג. אנטיביוטיקה פומית מוכחת למניעת זיהומים במצב זה.

ד. בכוויות עם שלפוחיות מומלץ לנקז את הנוזל בשלפוחית עם מזרק.

122. בן 85, מתגורר בבית אבות. מתלונן על יציאות קשות בתקופה האחרונה, התדירות פחותה מבעבר ובין היציאות סובל מנפיחות ואי נעימות בטנית.
מהו הצעד הראשון בטיפול?

א. Fleet Enema (על בסיס Sodium phosphate).

ב. סיר לילה זמין ליד מיטתו.

ג. Avilac (Lactulose).

ד. הליכה לשירותים לאחר כל ארוחה.

123. בת 50, ברקע - יתר לחץ דם, מטופלת ב- Nifedipine 60 מ"ג ביום. מזה חצי שנה מתלוננת על כאב עז וחיוורון בכפות ידיים ורגליים, הכאב מופיע לסירוגין ומחמיר בחשיפה לקור. הממצא בבדיקה גופנית מתואר בתמונה:



מהו הטיפול המומלץ ביותר בשלב זה?

- א. להחליף Nifedipine ל-Bisoprolol.
- ב. להוסיף Phosphodiesterase 5 inhibitor.
- ג. להוסיף Methotrexate.
- ד. להפנות לפוטותרפיה.

124. בת 6, הובאה לבדיקה לאחר שאביה מספר כי מזה מספר שעות אינה מזיזה את יד שמאל מאז שמשך אותה בידה בעת שחזרה מהגן. ללא נפילה או חבלה. הילדה נראית רגועה ונינוחה אך לא מניעה את יד שמאל.
מהו הטיפול הנכון ברגע זה?

- א. ביצוע סופינציה ולאחר מכן פלקסיה של האמה.
- ב. ביצוע סיבוב אחורי של כתף שמאל.
- ג. צילום מרפק.
- ד. קיבוע ע"י מתלה.

125. על תרופה חדשה נמסר שהיא מקטינה את הסיכון היחסי ללקות בסוכרת בקרב חולי IFG ב-50% בהשוואה לקבוצת הביקורת שלא קיבלה את התרופה.
מנתונים אלה מה נדרש כדי להשיג את יעד המטרה בחולה אחד?

- א. לטפל בתרופה בשני חולים.
- ב. לטפל בתרופה בחמישים חולים.
- ג. לדעת את שכיחות IFG באוכלוסייה.
- ד. לדעת את שיעור המעבר מ-IFG לסוכרת בקבוצת החולים הלא מטופלים.

126. מהי ההתייחסות לגבי תופעות הלוואי הבאות של גלולות למניעת הריון?

- א. בחילות בשעות הבוקר שמקשות על תפקוד יומיומי - ניתן לעבור לתכשיר עם מינון אסטרואגן נמוך יותר או להחליף לגלולת פרוגסטרון בלבד.
- ב. דימומים בתחילת המחזור שנמשכים מעל שלושת חודשי שימוש בגלולה - יש להחליף לתכשיר עם מינון אסטרואגן נמוך יותר.
- ג. דימומים במחצית השנייה של המחזור שנמשכים מעל שלושה חודשים - יש להחליף לתכשיר עם מינון פרוגסטרון נמוך יותר.
- ד. המרכיב האסטרואגני בעל השפעה מגנה לבבית ולכן לנשים בסיכון מוגבר יחסית עדיפות גלולות עם מינון אסטרואגני גבוה יותר.

127. בת 32 מלינה על כאבי שדיים ב-3 החודשים האחרונים. ללא היסטוריה משפחתית של סרטן שד בקרובי משפחה מדרגה ראשונה.
מה מצביע על בעיה המחייבת המשך ברור?

- א. שימוש מזה חצי שנה בגלולות משולבות חדשות.
- ב. הפרשה ספונטנית סרוטית מהפיטמה.
- ג. נוטלת באופן קבוע טיפול אנטיפסיכוטי דוגמת Risperdal (Risperidone).
- ד. הכאבים הכי חמורים לאחר כשבועיים מתחילת הווסת.

128. בן 70, מבצע בדיקות PSA לבקשתו ללא כל תלונות גופניות או ממאירות ערמונית במשפחה.
בבדיקות מעבדה שגרתיות PSA עלה מ-2 ל-3.5 ng/ml בשנה האחרונה.
מה הבדיקה הבאה שיש לבצע?

- א. ביופסיית ערמונית.
- ב. תרביית שתן לשלילת זיהום בדרכי שתן.
- ג. PET CT לחיפוש מחלה גרורתית.
- ד. בדיקת PSA חוזרת בעוד חצי שנה.

129. בן 30, בריא בדרכי, מתאר שמרגיש מזה חודש אי נוחות ונפיחות באשך השמאלי, ללא כאבים ניכרים או רגישות מקומית. לא משתנה במנח. שולל תלונות אורिनריות נוספות או טראומה. מספר שנותח בינקות עקב אשך טמיר.
מהי הבדיקה המתאימה ביותר בשלב זה?

- א. בדיקת דם ל-LDH ו-Alpha-fetoprotein (AFP).
- ב. סונר אשכים.
- ג. סונר מפשעות כולל הרניה.
- ד. CT חזה ובטן.

130. בת 38, בריאה בד"כ, ללא טיפול תרופתי קבוע, לא מעשנת, ללא אלרגיות ידועות. מתלוננת על נזלת מוגלתית, שיעול קל, כאב ראש מזה 4 ימים. בבדיקתה: במצב כללי טוב, מדדים חיוניים תקינים, ריאות נקיות, רגישות בניקוש הסינוסים הפרונטליים. מהו הטיפול המומלץ במקרה זה?

- א. Augmentin ותרסיס סטרואידים.
- ב. אנטי-היסטמינים פומי.
- ג. Prednisone דרך הפה.
- ד. שטיפות אף עם מי מלח, מפיגי גודש.

131. בת 7 שנים, בריאה בדרך כלל. בשלושה חודשים האחרונים היו 7 ביקורים במרפאה ובמיון. כל ביקור מתארת אירוע חריף של כאב בטן עז, סחרחורות, בחילות והקאות. האירוע נמשך כ-3 שעות, כעבור 3 שעות נרדמת ואז האירוע חולף. בין האירועים מרגישה טוב. בבדיקה גופנית - רגישות ניכרת דיפוזית בבטן בזמן התקף, ללא ממצא נוסף במישוש. במעבדה: בדיקות צואה ומדדי דלקת תקינות. מהי האבחנה הסבירה ביותר?

- א. Functional vomiting
- ב. Familial Mediterranean fever
- ג. Abdominal Migraine
- ד. Recurrent Appendicitis

132. בן 34, בריא בד"כ, ללא טיפול קבוע. אינו מעשן/צורך סמים או אלכוהול. מלין על כאבי גב גבי אשר החלו באופן הדרגתי כ-3 שבועות טרם ביקורו, מוחמרים בפעילות ולא מוקלים בשכיבה. ביממה האחרונה ממעט במתן שתן ומתאר נימול באזור מפשעה. מהי הבדיקה שיש לבצע באופן מידי?

- א. מיפוי עצמות.
- ב. בדיקת EMG.
- ג. צילום עמוד שדרה.
- ד. CT עמוד שדרה.

133. מתוכנן מחקר שמטרתו לבדוק האם אכילת בשר אדום הינו גורם סיכון להתפתחות סכרת. אין הגבלה בזמן, בצוות ובמשאבים.
מהו סוג המחקר הטוב ביותר לבדוק את ההשערה?

- א. מחקר RCT.
- ב. מחקר Case Control.
- ג. מחקר Retrospective Cohort.
- ד. מחקר Prospective Cohort.

134. מהו המאפיין הנכון ביותר לגבי שימוש בהתקן תוך רחמי?

- א. אינו מומלץ עקב סיכון מוגבר לזיהום.
- ב. התקן משחרר הורמונים עדיף עקב יעילות למשך 10 שנות שימוש.
- ג. מהווה אמצעי המניעה היעיל ביותר.
- ד. מהווה אמצעי מניעה בחרום (emergency contraception) עד שבועיים ממגע מיני לא מוגן.

135. באיזה מטופל ניתן יהיה לאבחן מחלת צליאק (Celiac Disease) ללא צורך בביצוע גסטרוסקופיה ולקיחת ביופסיה?

- א. בן שנה, ללא תסמינים, אחותו אובחנה כסובלת ממחלת צליאק, בדיקת Anti-tissue transglutaminase (anti-tTG) פי 2 מערכי הנורמה.
- ב. בן 9 חודשים, לאחר תחילת אכילת גלוטן, סובל מהאטה בצמיחה, דלדול שרירים ותפיחות בטנית, Anti-tissue transglutaminase (anti-tTG) פי 3 מהנורמה.
- ג. בן שנתיים עם עצירת גדילה ואנמיה של חסר ברזל, בדיקת Anti-tissue transglutaminase (anti-tTG) וערכי total IgA תקינים.
- ד. בן שנה וחצי עם עצירת עקומות גדילה, בבדיקה ערכי Anti-tissue transglutaminase מעל 10X מהנורמה, Endomysial Ab's חיוביים ובדיקת HLA מתאימה חיובית.

136. במחקר RCT לא צוין שהופעל עקרון Intention To Treat Analysis. מהי משמעות נתון זה לגבי תוצאות המחקר?

- א. התוצאות במחקר לא משקפות מחקר טיפולי (Intention To Treat).
- ב. התוצאות במחקר כנראה לא משקפות את המציאות וסביר להניח שאחוז הנשירה מהמחקר היה גבוה.
- ג. התוצאות במחקר משקפות את המציאות היות ומדובר במחקר RCT עם Per Protocol Analysis שהינה שיטה מדויקת יותר לקבלת האפקט המצופה.
- ד. התוצאות במחקר משקפות את המציאות כיון ש- Intention To Treat Analysis משפיעה בעיקר על אותם נבדקים שעליהם התרופה לא השפיעה.

137. בן 28 פנה מיד לאחר נפילה מאופניים. בהגעתו אוחז עם ידו השמאלית את זרוע ימין, מתאר כי בעת שנפל ניסה לבלום את הנפילה עם יד ימין מושטת. מאז מתקשה להזיז את הזרוע הימני. שולל חבלות משמעותיות נוספות. בהסתכלות נראית דפורמציה קלה באזור כתף ימין, עם גומה מתחת לאקרומיון לטרלית. טווח תנועה מוגבל בשל כאבים, מיששת את ראש ההומרוס באקסילה. מהו הטיפול המתאים ביותר?

- א. תיקון ניתוחי.
- ב. שיחזור ופיזיותרפיה בהקדם.
- ג. טיפול באנלגטיקה חזקה ומעקב למשך 24 שעות.
- ד. שיחזור, צילום וקיבוע של היד למשך שבועיים.

138. בת 32, בריאה בד"כ, פונה לבדיקה בשל נפיחות בצוואר מזה חודש. באנמנזה ללא סיבה ברורה לנפיחות, ובבדיקתה נמושה בלוטת למפה בקוטר 1.5 ס"מ. שאר הבדיקה הגופנית תקינה. מהו השלב הבא המתאים ביותר לבירור?

- א. ביקורת עוד חודש.
- ב. צילום חזה.
- ג. US בטן עליונה.
- ד. ביופסיה מסוג FNA.

139. את/ה מעוניין/ת לתכנן מחקר שבודק את הקשר בין החשיפה למי שתיה לא רתוחים ותחלואה גסטרואינטסטינלית.

מה יהיו היתרונות במחקר cross sectional במקרה זה?

- א. הסיכוי להטיות במחקר קטן ביותר.
- ב. המחקר מהיר ומספק קשר סיבתי בין החשיפה (שתיית מים לא רתוחים) לתוצאה (תחלואה גסטרואינטסטינלית).
- ג. המחקר מאפשר לקבל Odds Ratio – בין הסיכוי לחשיפה למי שתיה לא רתוחים בקרב מקרי התחלואה הגסטרואינטסטינלית לבין הסיכוי לחשיפה למי שתיה לא רתוחים בקרב הבריאים.
- ד. המחקר מאפשר לקבל Relative Risk – הסיכון היחסי לתחלואה גסטרואינטסטינלית בקרב אלו השותים מי שתיה לא רתוחים לעומת אלו השותים מי שתיה רתוחים.

בשאלות הבאות התשובה היא דרך השלילה.

140. בן 75, לפני חמש שנים עבר CVA מאז נותר עם Rt.Hemiparesis, הולך בעזרת מקל. מזה חודש מתלונן על נפילות מרובות וקושי להרים את היד השמאלית. בבדיקתו - ללא חסר קוגניטיבי. לא מסוגל להרים את יד שמאל, היד רפה, עם פאסיקולציות בשרירי הזרוע ורפלקס Biceps ירוד. מהי הסיבה הפחות סבירה למצבו?

- א. שבר ב- NECK OF HUMERUS השמאלי עקב נפילה.
- ב. אירוע מוחי נוסף (CVA).
- ג. דיסלוקציה של דיסק צווארי C6.
- ד. Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).

141. 5 דקות לפני סגירת המרפאה התקבלה שיחת טלפון דחופה ממטופלת בת 65 אשר מדווחת שנכדה בן שלוש שנים בלע כדור (תרופה) שלה בעת ששמרה עליו. באיזה מקרה אין צורך בהפניה דחופה למיון?

- א. במידה ובלע כדור Deralin (Propranolol).
- ב. במידה ובלע כדור Amaryl (Glimepiride).
- ג. במידה ובלע כדור Aspirin (Acetylsalicylic acid).
- ד. במידה ובלע כדור Elatrol (Amitriptyline).

142. בת 55, מגיעה למרפאה מוטרדת לאחר שאביה אובחן עם דמנציה. היא בריאה ברקע, אינה מעשנת. שואלת כיצד תוכל למנוע הופעת המחלה אצלה. אילו מהממצאים הבאים לא הוכח כיעיל בהפחתת היארעות של דמנציה?

- א. דיאטת Atkins.
- ב. שתייה מתונה של אלכוהול.
- ג. משחק פינג-פונג.
- ד. לימוד שפה חדשה.

143. בת 32, ברקע – תסמונת המעי הרגיש (IBS), מתלוננת על כאבים בבטן התחתונה לפני ובעת הטלת שתן, אירועי הכאב חוזרים ונמשכים מספר חודשים. שוללת חום/הפרשות/גרד וגינלי. בדיקת שתן בסטיק - לויקוציטים ++, ללא ניטריטים, ללא אריטרוציטים. נלקחה תרבית שתן. הוחל טיפול אמפירי ב-Nitrofurantoin ללא הטבה במצבה. תרבית שתן חזרה עקרה, בדיקת PCR ל-STD שלילית. מי מהבאים הכי פחות יעיל לטיפול באבחנה הסבירה?

- א. טיפול ב-Prednisone 30 מ"ג למשך שבועיים.
- ב. פיזיותרפיה של רצפת האגן.
- ג. טיפול ב-Amitriptyline.
- ד. הפניה לטיפול רגשי/פסיכולוגי.

144. מה מהבאים לא מחשיד לתסמונת קושינג?

- א. שיעור יתר.
- ב. חבורות קלות.
- ג. התכווצויות שרירים.
- ד. שרירים רפויים.

145. בת 9, סובלת מאירועים חוזרים של כאבים בשוקיים בחודש האחרון.

מה ישלול אבחנה של Benign Nocturnal pain of childhood?

- א. הכאב הוא חד צדדי.
- ב. הכאב מעיר מהשינה.
- ג. הילדה בשלב Tanner 0.
- ד. יש כאב גם בזרועות.

146. במסגרת תוכנית לשיפור רפואה מרחוק כחלק מזיהוי מצבי חירום הועלה נושא "שיחה טלפונית

בעקבות כאבי חזה אנגינוטיים".

איזה מהקריטריונים הבאים לא נכלל ל"telephone triage" של ACS (acute coronary syndrome)?

- א. כאב שבהתחלה היה קשור למאמץ פיזי וכרגע מופיע במנוחה.
- ב. כאב בחזה שמלווה בקשיי בליעה.
- ג. כאבים בחזה מעל 20 דקות.
- ד. כאב בחזה מלווה בקוצר נשימה.

147. בן 40, מגיע עם תלונה של צואה בהירה ושתן כהה. באנמזה - ללא כאבי בטן/ירידה במשקל/חום או תלונות סיסטמיות. שולל שימוש בתרופות או נסיעות לחו"ל. בבדיקה - התרשמת בהסתכלות מזהבת בלחמיות. בטן רכה, משרעת הכבד תקינה, סימן מרפי שלילי.
מי מהברורים הבאים לא יקדם את האבחנה?

א. בירור מעבדתי לחסר G6PD.

ב. סטיק שתן לבילירובין.

ג. בדיקות מעבדה ל-PT ואלבומין.

ד. סונר בטן עליונה.

148. מהי אינה החלטה טיפולית נכונה במקרה של Microscopic Hematuria?

א. בת 50, מתלוננת על צריבה במתן שתן. בבדיקת שתן – 4 RBC בשדה, תרבית שתן עקרה. תטופל באסטרוגן נרתיקי.

ב. בן 50, סובל מפרפור פרזדורים, מטופל ב-Dabigatran. בבדיקת שתן – 20 RBC בשדה. יפסיק Pradaxa כי זה, כנראה, סיבה לדימום.

ג. בן 65, ברקע עישון כבד. ללא תלונות אורינויות, בבדיקת שתן - 10 RBC בשדה. יבצע ציסטוסקופיה בהקדם.

ד. בן 70, סובל מהיסוס וטפטוף במתן שתן, בבדיקת שתן – 5RBC בשדה, תרבית שתן עקרה. יטופל ב-Xatral (Afluzosin).

149. באיזה מקרה אין צורך לבדוק נוכחות החיידק Helicobacter Pylori?

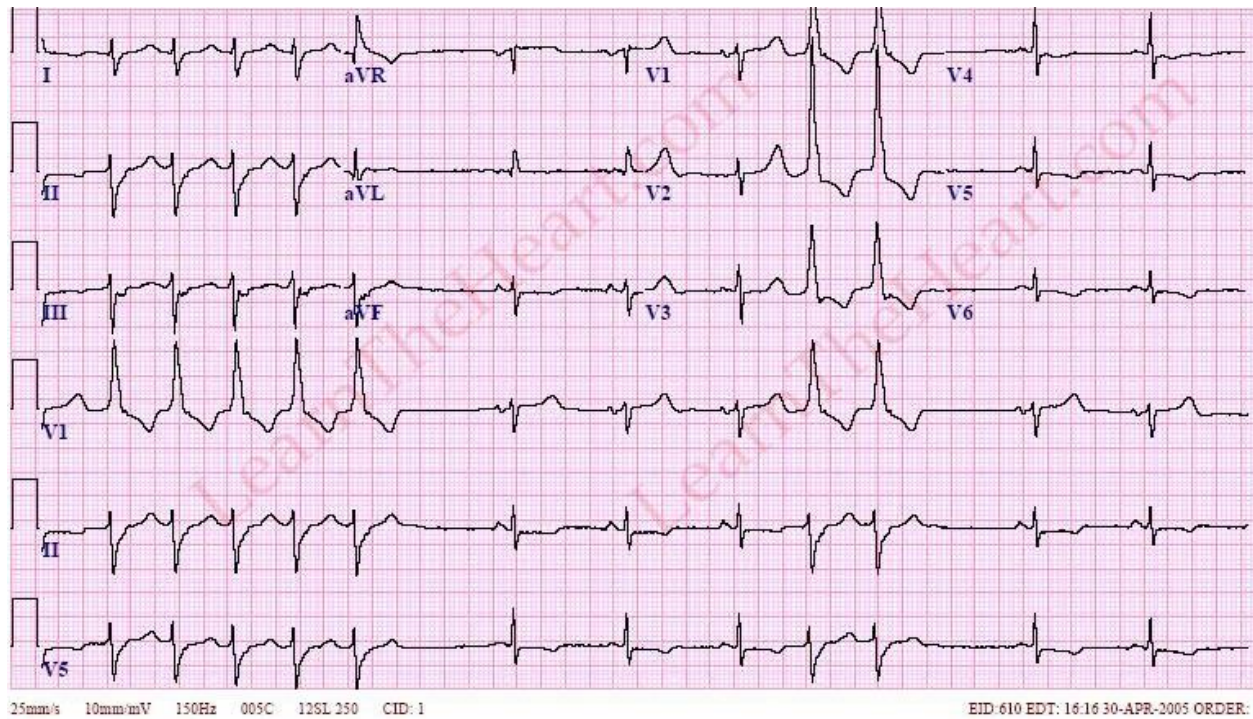
א. גבר מתלונן על צרבת, ידוע על תסמונת GERD.

ב. אשה מאובחנת כסובלת מ-ITP (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura).

ג. גבר שבעברו כיב פפטי בתריסריון.

ד. אשה שסובלת מחסר ברזל וגסטריטיס אטרופית.

150. בן 40, ברקע - יתר לחץ דם, מפתח פלפיטציות בזמן מבחן מאמץ (מצורף תרשים ה-ECG).



איזו תרופה מהבאות לא סביר שמהווה סיבה להפרעת הקצב המודגמת בתרשים?

- א. Montelukast
- ב. Sertraline
- ג. Clarithromycin
- ד. Risperidone

בהצלחה